KULIAH BLOK REPRODUKSI

Asuhan Antenatal (ANC)

Garis Pertahanan Utama Keselamatan Ibu dan Janin

Maisuri T Chalid

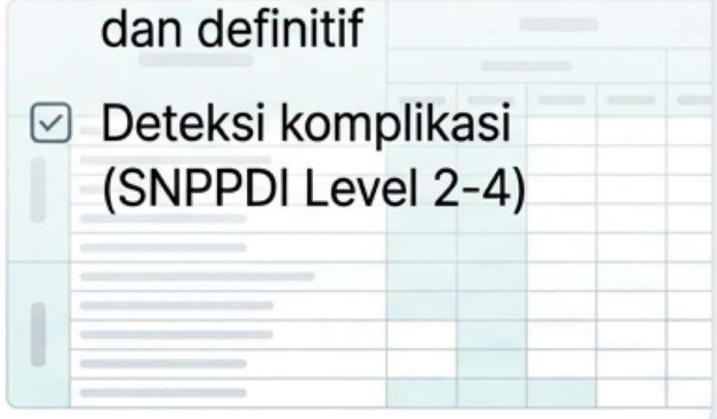
Peta Kompetensi Klinis Asuhan Antenatal

Identifikasi & Diagnosis

- ☑ Aplikasi fisiologi kehamilan (Tanda & Gejala)
- ☑ Identifikasi faktor risiko klinis
- ☑ Diagnosis & Diagnosis Banding via anamnesis, fisik, dan penunjang

Penatalaksanaan

- ☑ Penentuan pemeriksaan penunjang yang relevan
- ☑ Penatalaksanaan awal dan definitif
- ☑ Deteksi komplikasi (SNPPDI Level 2-4)



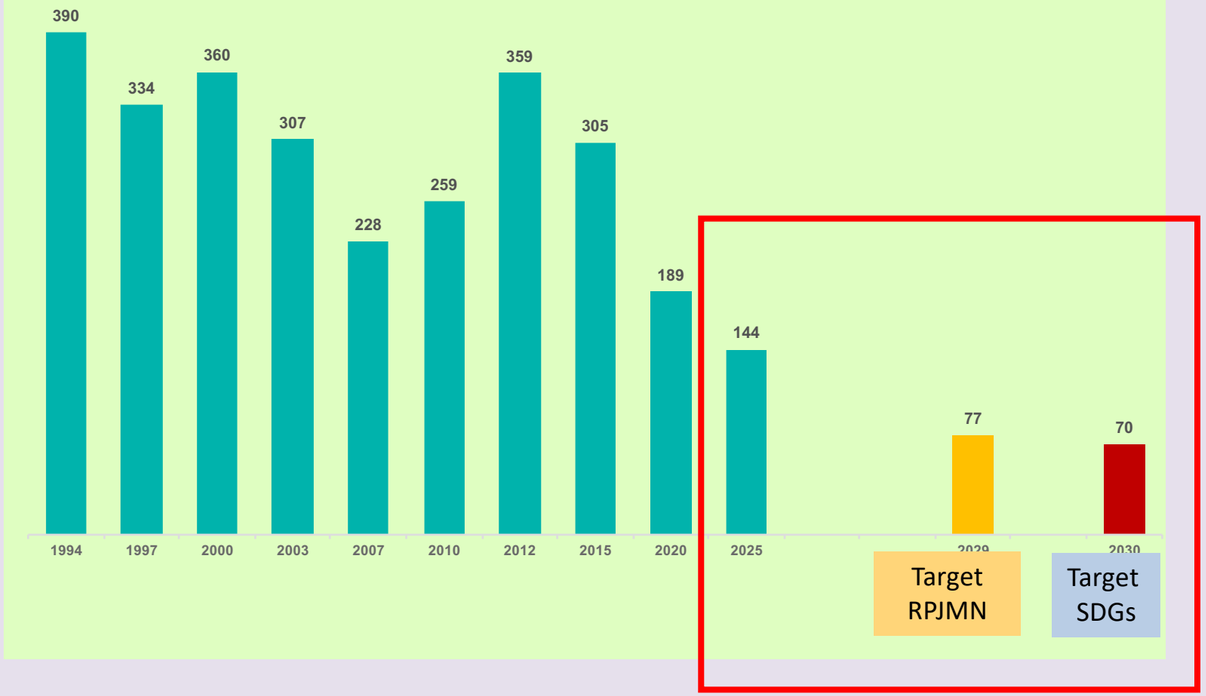
Edukasi & Intervensi

- ☑ Pencegahan komplikasi (Kehamilan, Persalinan, Nifas)
- ☑ Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE)

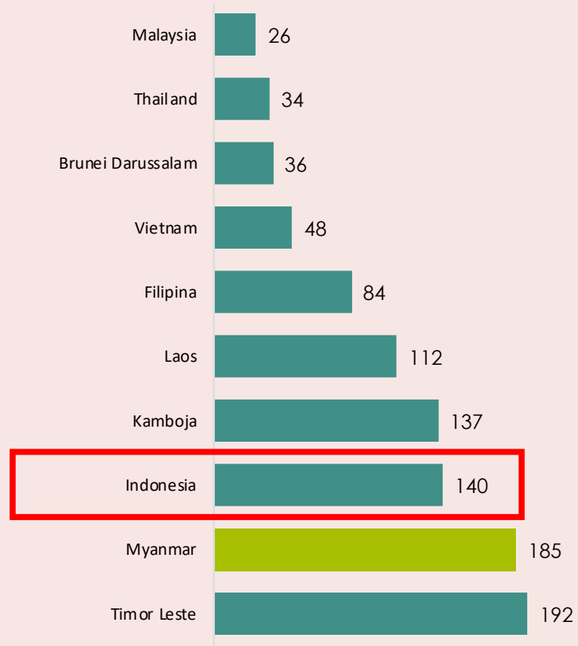
Pendahuluan → *Update* AKI Terkini

AKI di Indonesia telah mengalami penurunan → **Namun belum sebaik negara² lain di Asia Tenggara**

Target SDGs 2030 menuntut penurunan drastis. ANC adalah instrumen utama untuk menutup kesenjangan ini.

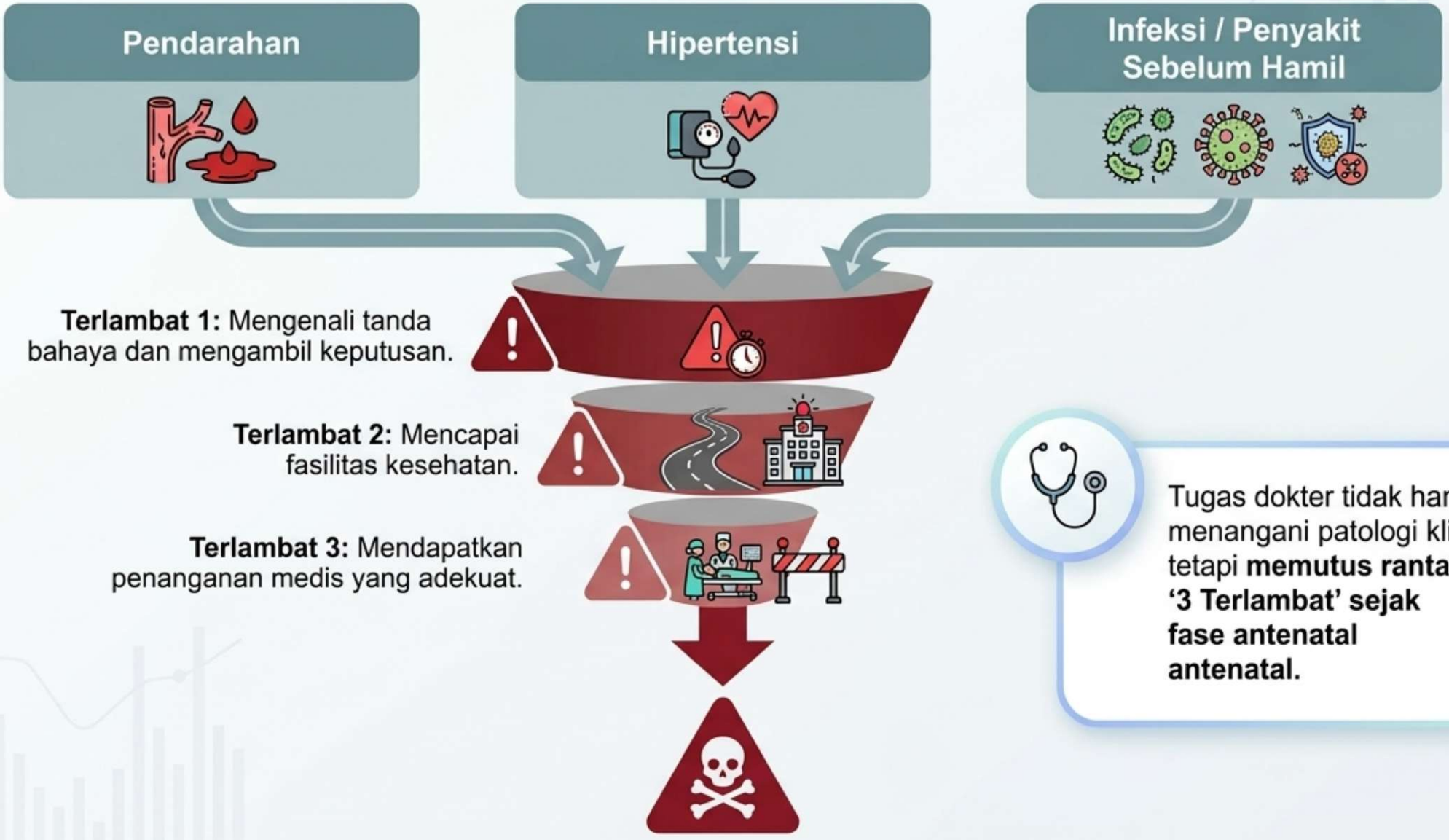


AKI per 100.000 KH di Negara² ASEAN Tahun 2023



World Health Organization. Global Health Observatory: Maternal mortality ratio (per 100,000 live births). Geneva: World Health Organization; 2025.
Badan Pusat Statistik. SUPAS 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2026.
Kementerian PPN/Bappenas. Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas; 2025.

Akar Masalah Kematian Ibu: Patologi dan Hambatan Sistem



Tugas dokter tidak hanya menangani patologi klinis, tetapi **memutus rantai '3 Terlambat' sejak fase antenatal antenatal.**

Gemini Notebook

ANC: Intervensi Proaktif Pemantauan dan Persiapan

Deteksi & Rujukan

Mengenali dini kelainan/komplikasi dan penatalaksanaan awal.

Pemantauan

Memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin.



Definisi WHO (2016):
Perawatan medis profesional untuk memastikan kondisi kesehatan terbaik bagi ibu dan bayi.

Persiapan Persalinan

Memastikan persalinan cukup bulan, bersih, aman, meminimalkan trauma.

Persiapan Nifas & ASI

Kesiapan fisik/mental pasca persalinan.

Standar Pelayanan ANC: Sistem 10T (Fase Klinis Dasar)

1



Timbang Badan & Tinggi Badan (Status gizi dasar).

2



Tekanan Darah (Screening preeklampsia).

3



Tinggi Fundus Uteri (Kesesuaian usia kehamilan)

4



Tentukan Presentasi & DJJ (Kondisi dan posisi janin).

5



Tertib Nutrisi/Gizi.

Standar Pelayanan ANC: Sistem 10T
(Intervensi & Edukasi)

6



Tablet Fe
(Minimal 90 tablet selama kehamilan).

7



Tetanus Toxoid
(Imunisasi TT).

8



Tes Laboratorium
(Hb, Golongan Darah, Urin, HIV, HBsAg, Sifilis).

9



Tata Laksana Khusus
(Penanganan medis spesifik).

10



Temu Wicara / Konseling
(Edukasi dan persiapan).

Paradigma Kunjungan 2021: Kapan Dokter Harus Intervensi?



Trimester I (K1 - Sebelum M12):
Mandat Dokter
- Skrining preeklampsia dan deteksi dini kelainan medis.

Trimester II (Antara M24-28):
2 Kali kunjungan.

M38

Trimester I, <M12

2 3 4 5

Minggu 0 Minggu 12 Minggu 24 Minggu 28 Minggu 30 Minggu 34 Minggu 40+

Trimester III (Antara M30-38):
3 Kali kunjungan.
Mandat Dokter - Evaluasi akhir medis dan obstetri.

Minimal 6x kunjungan total. Minimal 2x pemeriksaan wajib oleh Dokter (Trimester 1 & 3).

Anatomi Anamnesis: Membangun Profil Risiko Pasien

1 Klinis Saat Ini

Demam, pendarahan, nyeri kepala/perut, gerak janin, muntah berlebihan, sesak nafas.



2 Riwayat Medis & Obstetri

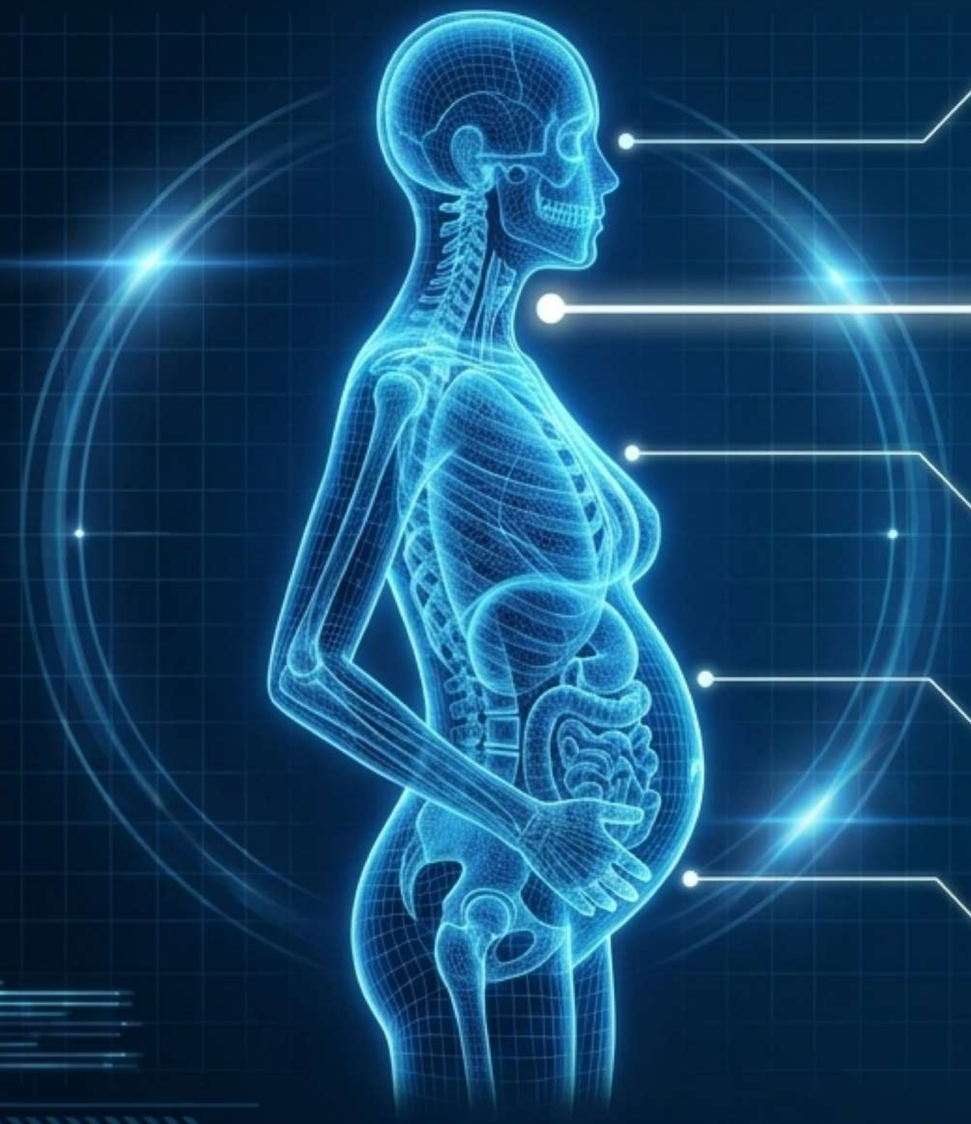
Riwayat HAP/HPP (Perdarahan hamil/nifas), SC/operasi, makrosomia/ IUGR, Riwayat keluarga (DM, HT, Jantung).

3 Sosio-Ekonomi (Solusi '3 Terlambat')

- Siapa pembuat keputusan di rumah? (Solusi Terlambat 1)
- Transportasi dan kesiapan merujuk? (Solusi Terlambat 2)
- Kesiapan pendonor darah?

Riwayat sosial sama pentingnya dengan riwayat klinis dalam mencegah mortalitas.

Pemeriksaan Fisik: Deteksi Sistemik (Head-to-Toe)



1. Tanda Vital & Fokus Nadi

Tanda Vital: TD, Suhu, Nafas.
Fokus Nadi: Deteksi awal kelainan irama jantung.

2. Leher (Sangat Penting)

Tekanan Vena Jugularis (JVP) & Tiroid (Sering terlewatkan namun bermakna klinis besar).

3. Jantung & Paru

Pemeriksaan auskultasi detail.

4. Abdomen

Identifikasi luka insisi operasi sebelumnya.

5. Status Gizi

BB, TB, LILA (Lingkar Lengan Atas).

Skrining Preeklampsia (Usia Kehamilan < 20 Minggu)

	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Faktor Risiko	• Nulipara, Umur >35, • Obesitas (IMT >30), • Jarak kehamilan >10th, • Riwayat PE keluarga, • MAP > 90mmHg, • Kehamilan IVF.	• Riwayat PE sebelumnya, • Kehamilan multipel, • DM, Hipertensi Kronik, • Penyakit Ginjal, • Autoimun/SLE, APS.

JIKA [2 Risiko Sedang (Kuning)] **ATAU** [1 Risiko Tinggi (Merah)] = Lakukan RUJUKAN terencana.

Profilaksis: Berikan Kalsium (1000-1500 mg/hari) & Aspirin (80 mg/hari).

Skrining Diabetes Melitus Gestasional (Usia 24-28 Minggu)

Identifikasi Risiko Tinggi (>2 Kriteria)

Obesitas, Riwayat DM Keluarga (1st degree), Riwayat toleransi glukosa terganggu, Riwayat bayi makrosomia, Glukosuria.

Pemeriksaan Awal

Cek Gula Darah Sewaktu (GDS).

Diagnostik Lanjutan (24-28 Minggu)

Gula Darah Puasa & Gula Darah 2 Jam Post Prandial (2JPP).

Blueprint Klinis: Pemetaan Tindakan Sesuai Standar

	Trimester I	Trimester II	Trimester III
Fisik & Obstetrik			
Tinggi Fundus & DJJ	●	●	●
Manuver Leopold		●	●
Laboratorium Wajib			
Hb, Protein Urin, Urin Reduksi	●		●
Golongan Darah, HIV, Sifilis, HBsAg, Gula Darah	●		
Penunjang & Intervensi			
USG Dasar	●		●
Fe & Asam Folat	●	●	●

Dokter menyatukan data klinis, laboratorium, dan skrining risiko untuk membuat rekomendasi rujukan dini.

Sintesis Alur ANC Terpadu & Stratifikasi Penanganan



Titik Kritis Asuhan Antenatal (Takeaways)

Transisi ke 8 Kontak Aktif. Kualitas intervensi dan deteksi dini jauh lebih bermakna daripada sekadar menghitung kehadiran fisik (kunjungan).

Disiplin pada Framework 10T. Ceklis 10T bukan sekadar **administrasi,** melainkan tameng utama keselamatan ibu dan janin. **K1 wajib oleh Dokter.**

Jangan Lewatkan Skrining Mayor. Stratifikasi risiko Preeklampsia (<20 minggu) dan Skrining DMG (24-28 minggu) adalah intervensi absolut untuk mencegah '3 Terlambat'.

CAPAIAN: PERSALINAN AMAN





Pengisian Buku KIA

Pencatatan Kesehatan Ibu yang sudah Diterima

Berisi ringkasan pelayanan esensial ibu selama hamil – sekaligus sumber data untuk memantau pencapaian 12T



Pencatatan Pelayanan Kesehatan Ibu yang Sudah Diterima

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan mengisi data dan paraf sesuai layanan yang diberikan.

HPHT/Trimester	I 12 Minggu Pertama	II 13 - 28 Minggu		III Di Atas 28 Minggu		
Kunjungan ke-	1	2	3	4	5	6
Tanggal dan Tempat						
Tanggal periksa						
Tempat periksa						
Catatan Pemeriksaan						
Berat Badan						
Tinggi Badan						
Lingkar Lengan Atas						
Tekanan Darah						
Tinggi Rahim						
Letak dan Denyut Jantung bayi						
Status dan Imunisasi Tetanus						
Konseling						
Skrining Dokter						
Tablet Tambah Darah						
Tes Lab Hemoglobin (Hb)						
Tes Golongan Darah						
Tes Lab Protein Urine						
Tes Lab Gula Darah						
ISK Bakteri Urine						
USG						
Tripel Eliminasi (H/S/Hep B)						
Tata Laksana Kasus						

Lembar ini diisi oleh tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan mengisi tanggal dan tempat pemeriksaan sesuai usia kehamilan ibu:

- Trimester I jika usia kehamilan < 12 minggu
- Trimester II jika usia kehamilan 13 – 28 minggu
- Trimester III jika usia kehamilan > 28 minggu

1. **Tenaga kesehatan mengisi setiap kolom sesuai hasil** pemeriksaan yang telah diperoleh Ibu di tiap kunjungan kehamilan pada tiap trimester
2. **Tenaga kesehatan membubuhkan paraf** sesuai jenis pelayanan yang telah diberikan
3. Untuk **kolom yang berwarna abu-abu**, tidak perlu diisi. Contoh: ibu diukur LILA hanya pada saat ANC pertama kali, idealnya di TM I. **Namun**, jika ibu datang ANC pertama kali pada TM II, ibu tetap diukur LILA dan hasil pengukuran diisi pada kolom sesuai usia kehamilan di TM II/sesuai kunjungan.

Kasus #1

Kunjungan ANC pertama di BPM, pada usia kehamilan 12 minggu

Pencatatan Pelayanan Kesehatan Ibu yang Sudah Diterima

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan mengisi data dan paraf sesuai layanan yang diberikan.

HPHT/Trimester	I 12 Minggu Pertama	II 13 - 28 Minggu		III Di Atas 28 Minggu		
Kunjungan ke-	1	2	3	4	5	6
Tanggal dan Tempat						
Tanggal periksa	4/2/26					
Tempat periksa	BPM Nur					
Catatan Pemeriksaan						
Berat Badan	59kg DA					
Tinggi Badan	155cm DA					
Lingkar Lengan Atas	28cm					
Tekanan Darah	110/70 DA					
Tinggi Rahim	2ja-simp TR					
Letak dan Denyut Jantung bayi	Ball+ DJJ + TR					
Status dan Imunisasi Tetanus	lengkap TR					
Konseling	perawatan kes umum TR					
Skrining Dokter	tdk					
Tablet Tambah Darah	30 tablet TR					
Tes Lab Hemoglobin (Hb)	—					
Tes Golongan Darah	A+ TR					
Tes Lab Protein Urine	—					
Tes Lab Gula Darah						
ISK Bakteri Urine	—					
USG	tidak TR					
Tripel Eliminasi (H/S/Hep B)	— — —					
Tata Laksana Kasus	anjurkan ibu periksa kesh + USG di dokter PKM TR					

Karena belum terpenuhi standar pelayanan K1 – maka anjurkan ibu untuk segera ke puskesmas

Pencatatan Pelayanan Kesehatan Ibu yang Sudah Diterima

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan mengisi data dan paraf sesuai layanan yang diberikan.

HPHT/Trimester	I 12 Minggu Pertama	II 13 - 28 Minggu		III Di Atas 28 Minggu		
Kunjungan ke-	1	2	3	4	5	6
Tanggal dan Tempat						
Tanggal periksa	4/2/26	18/2/26				
Tempat periksa	BPM Nur	PKM KBJR				
Catatan Pemeriksaan						
Berat Badan	59kg DA	59kg SM				
Tinggi Badan	155cm DA					
Lingkar Lengan Atas	28cm DA					
Tekanan Darah	110/70 DA	100/70 SM				
Tinggi Rahim	2ja-simp TR	3ja-simp SS				
Letak dan Denyut Jantung bayi	Ball+ DJJ + TR	Ball+ DJJ + SS				
Status dan Imunisasi Tetanus	lengkap TR	lengkap SS				
Konseling	perawatan kes umum TR	6000 HPK Td bahaya SS				
Skrining Dokter	tdk	ya IP				
Tablet Tambah Darah	30 tablet TR	ada TR				
Tes Lab Hemoglobin (Hb)	—	11,3 SS				
Tes Golongan Darah	A+ TR					
Tes Lab Protein Urine	—	neg SS				
Tes Lab Gula Darah		135 SS				
ISK Bakteri Urine	—	neg SS				
USG	tidak TR	ya IP				
Tripel Eliminasi (H/S/Hep B)	—	—	—	N	NR	NR
Tata Laksana Kasus	anjurkan ibu periksa kesh + USG di dokter PKM TR			Pertahankan pola makan IP		

Kunjungan ANC berikutnya sesuai anjuran BPM, ibu periksa ke Puskesmas pada usia kehamilan 14 minggu

Pada tahap ini maka standar pelayanan di TM 1 sudah terpenuhi.

minta ibu Kembali sebelum lewat 28 minggu untuk K3

Kasus #2

Jika kunjungan ANC pertama di Puskesmas, pada usia kehamilan 16 minggu

Pencatatan Pelayanan Kesehatan Ibu yang Sudah Diterima

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan mengisi data dan paraf sesuai layanan yang diberikan.

HPHT/Trimester	I 12 Minggu Pertama	II 13 - 28 Minggu		III Di Atas 28 Minggu		
Kunjungan ke-	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Tanggal dan Tempat						
Tanggal periksa		4/2/26				
Tempat periksa		PKM Kbjr				
Catatan Pemeriksaan						
Berat Badan		59 kg DA				
Tinggi Badan		155cm DA				
Lingkar Lengan Atas		28cm DA				
Tekanan Darah		110/70 DA				
Tinggi Rahim		½ pst-simp TR				
Letak dan Denyut Jantung bayi		Ball DJJ + TR				
Status dan Imunisasi Tetanus		lengkap TR				
Konseling		perawatan kes umum 1000HPK TR				
Skrining Dokter		+ IP				
Tablet Tambah Darah		30 tablet IP				
Tes Lab Hemoglobin (Hb)		11,0 SS				
Tes Golongan Darah		A+ SS				
Tes Lab Protein Urine		Neg SS				
Tes Lab Gula Darah		128 SS				
ISK Bakteri Urine		Neg SS				
USG		ya IP				
Tripel Eliminasi (H/S/Hep B)		NR NR N SS				
Tata Laksana Kasus		tidak ada IP				

Lakukan pelayanan untuk memenuhi standar pemeriksaan standar K1 dan catatkan sesuai dengan trimester kunjungan ibu

Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Halaman ini memberikan informasi evaluasi kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh **dokter/bidan/perawat**

Tenaga kesehatan mengisi hasil pengukuran Tinggi Badan (TB), Berat Badan (BB), Lingkar Lengan Atas (LiLa), dan **Indeks Massa Tubuh (IMT)** sesuai dengan kategorinya**.**

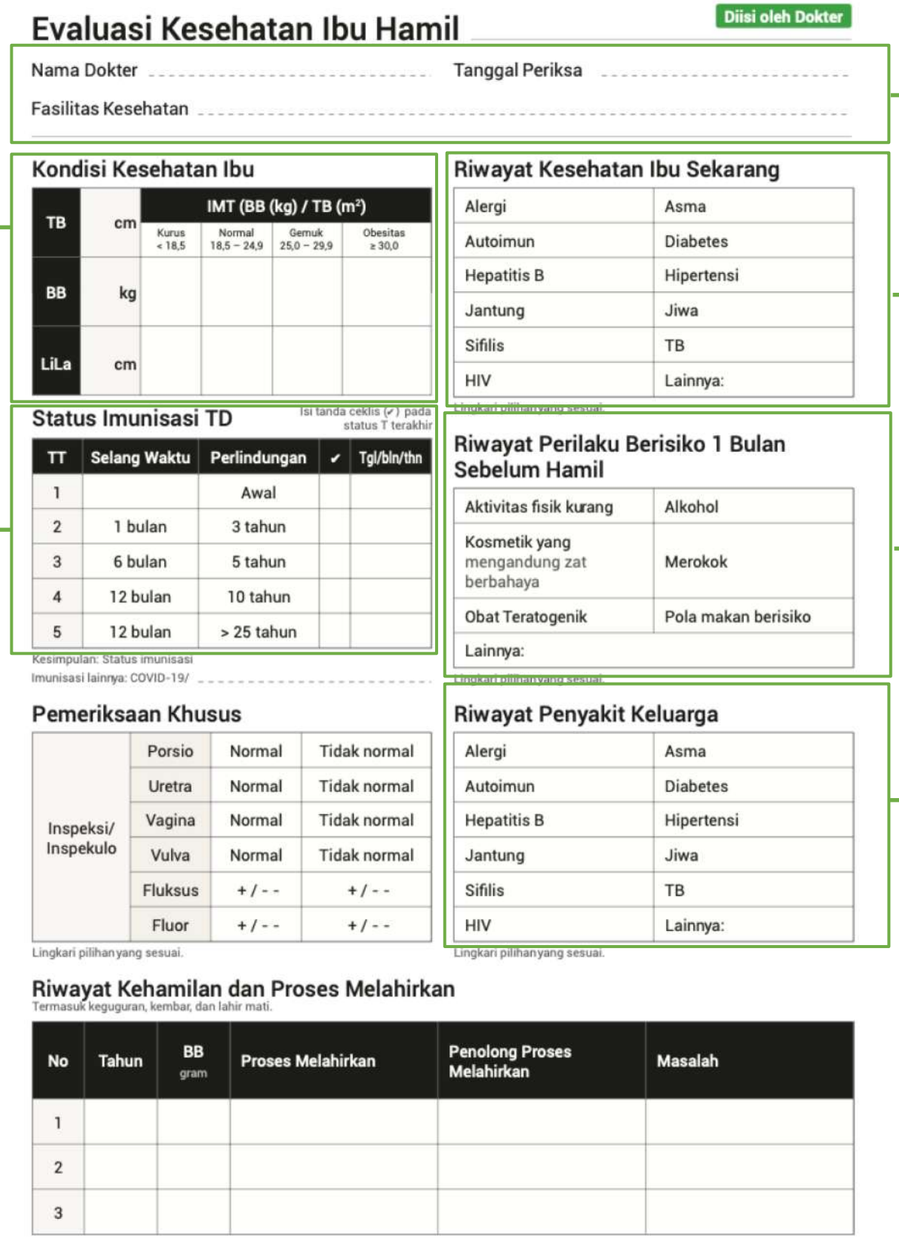
Indeks Massa Tubuh (IMT): BB ibu dalam kg dibagi TB ibu dalam kuadrat (kg/m^2).

Kategori IMT (sumber: PGS Ibu Hamil dan Ibu Menyusui, 2021):

1. Kurus: < 18,5 kg/m^2
2. Normal: 18,5 – 24,9 kg/m^2
3. Gemuk: 25,0 – 29,9 kg/m^2
4. Obesitas: ≥ 30,0 kg/m^2

Tenaga kesehatan mengisi status imunisasi TD dengan tanda checklist (**✓**) dan tanggal berdasarkan hasil skrining saat itu:

1. Jika dari hasil skrining ditemukan bahwa ibu telah memenuhi status T5 maka di-checklist (**✓**) pada kolom T5 dan tuliskan tanggal di sebelahnya.
2. Jika dari hasil skrining ditemukan bahwa ibu belum memenuhi T5 maka ibu membutuhkan imunisasi TD. Berikan imunisasi TD terlebih dulu, lalu di-checklist pada kolom sesuai status imunisasi terakhir pada hari itu dan ditulis tanggal di sebelahnya.



Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Diisi oleh Dokter

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Fasilitas Kesehatan .....

Kondisi Kesehatan Ibu

		IMT (BB (kg) / TB (m²))			
		Kurus < 18,5	Normal 18,5 – 24,9	Gemuk 25,0 – 29,9	Obesitas ≥ 30,0
TB	cm				
BB	kg				
LiLa	cm				

Riwayat Kesehatan Ibu Sekarang

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
HIV	Lainnya:

Lingkari pilihan yang sesuai.

Status Imunisasi TD

Isi tanda ceklis (✓) pada status T terakhir

TT	Selang Waktu	Perlindungan	✓	Tgl/bln/thn
1		Awal		
2	1 bulan	3 tahun		
3	6 bulan	5 tahun		
4	12 bulan	10 tahun		
5	12 bulan	> 25 tahun		

Kesimpulan: Status imunisasi

Imunisasi lainnya: COVID-19/ .....

Riwayat Perilaku Berisiko 1 Bulan Sebelum Hamil

Aktivitas fisik kurang	Alkohol
Kosmetik yang mengandung zat berbahaya	Merokok
Obat Teratogenik	Pola makan berisiko
Lainnya:	

Lingkari pilihan yang sesuai.

Pemeriksaan Khusus

Inspeksi/ Inspekulo	Porsio	Normal	Tidak normal
	Uretra	Normal	Tidak normal
	Vagina	Normal	Tidak normal
	Vulva	Normal	Tidak normal
	Fluksus	+ / - -	+ / - -
	Fluor	+ / - -	+ / - -

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Penyakit Keluarga

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
HIV	Lainnya:

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kehamilan dan Proses Melahirkan

Termasuk keguguran, kembar, dan lahir mati.

No	Tahun	BB gram	Proses Melahirkan	Penolong Proses Melahirkan	Masalah
1					
2					
3					

Tenaga kesehatan mengisi nama dokter yang memeriksa; nama faskes pemeriksa; dan tanggal/bulan/tahun pada saat dilakukan pemeriksaan

Tenaga kesehatan mengisi tabel riwayat kesehatan ibu saat ini **dengan melingkari pilihan yang sesuai**

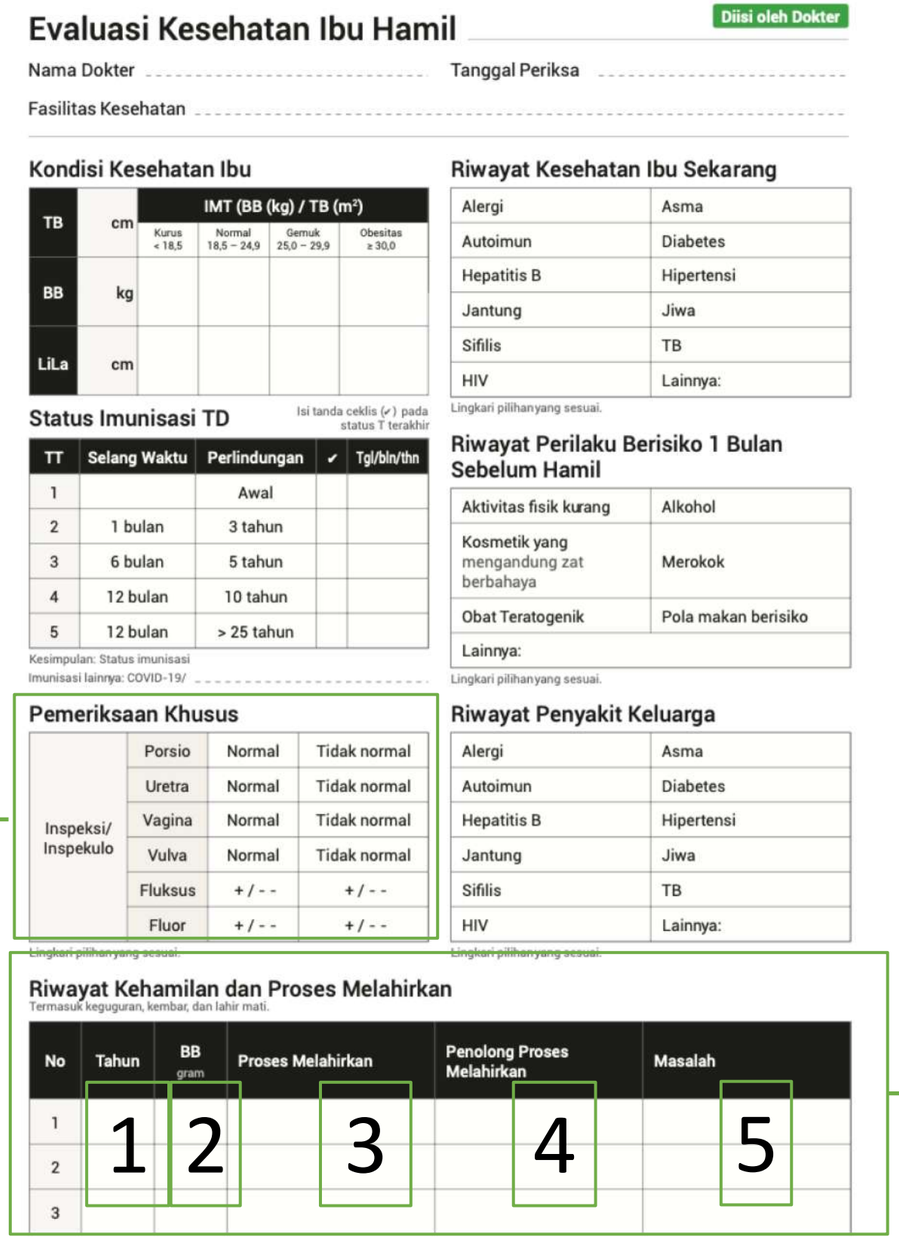
Tenaga kesehatan mengisi tabel riwayat perilaku berisiko ibu 1 bulan atau <30 hari sebelum hamil **dengan melingkari pilihan yang sesuai**

Tenaga kesehatan mengisi tabel riwayat penyakit keluarga dari ayah/ibu/kakek/ nenek/saudara yang memiliki hubungan darah **dengan melingkari pilihan yang sesuai**

Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Halaman ini memberikan informasi evaluasi kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh **dokter/bidan/perawat**

Tenaga kesehatan mengisi tabel pemeriksaan khusus **dengan melingkari pilihan yang sesuai** dengan keadaan ibu



Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Diisi oleh Dokter

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Fasilitas Kesehatan .....

Kondisi Kesehatan Ibu

		IMT (BB (kg) / TB (m²))			
TB	cm	Kurus < 18,5	Normal 18,5 – 24,9	Gemuk 25,0 – 29,9	Obesitas ≥ 30,0
BB	kg				
LiLa	cm				

Status Imunisasi TD

Isi tanda ceklis (✓) pada status T terakhir

TT	Selang Waktu	Perlindungan	✓	Tgl/bln/thn
1		Awal		
2	1 bulan	3 tahun		
3	6 bulan	5 tahun		
4	12 bulan	10 tahun		
5	12 bulan	> 25 tahun		

Kesimpulan: Status imunisasi

Imunisasi lainnya: COVID-19/ .....

Pemeriksaan Khusus

Inspeksi/ Inspekulo	Porsio	Normal	Tidak normal
	Uretra	Normal	Tidak normal
	Vagina	Normal	Tidak normal
	Vulva	Normal	Tidak normal
	Fluksus	+ / - -	+ / - -
	Fluor	+ / - -	+ / - -

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kesehatan Ibu Sekarang

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
HIV	Lainnya:

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Perilaku Berisiko 1 Bulan Sebelum Hamil

Aktivitas fisik kurang	Alkohol
Kosmetik yang mengandung zat berbahaya	Merokok
Obat Teratogenik	Pola makan berisiko
Lainnya:	

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Penyakit Keluarga

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
HIV	Lainnya:

Lingkari pilihan yang sesuai.

Riwayat Kehamilan dan Proses Melahirkan

Termasuk keguguran, kembar, dan lahir mati.

No	Tahun	BB gram	Proses Melahirkan	Penolong Proses Melahirkan	Masalah
1	1	2	3	4	5
2					
3					

Tenaga kesehatan mengisi riwayat kehamilan dan proses melahirkan ibu pada kehamilan sebelumnya, **dimulai dari riwayat kehamilan terakhir termasuk riwayat hamil dengan keguguran, kehamilan kembar dan lahir mati:**

1. **Kolom “tahun”**: diisi dengan tahun terjadinya kehamilan / kelahiran
2. **Kolom “BB”**: diisi dengan berat bayi (dalam gram) yang dilahirkan. Bila terjadi abortus, diisi dengan keterangan “abortus” atau “—”
3. **Kolom “proses melahirkan”**: diisi dengan metode persalinan yang dialami (spontan, vakum/forsep, seksio sesaria). Bila terjadi abortus, dapat disebutkan kuret/abortus spontan
4. **Kolom “penolong proses melahirkan”**: diisi dengan jenis penolong persalinan seperti dokter, bidan, perawat, SpOG, dll.
5. **Kolom “masalah”:** diisi dengan masalah yang dialami dalam kehamilan/persalinan tersebut, misalnya premature, PJT, PEB, perdarahan, dll. Sebutkan juga kondisi anak saat ini (sehat/meninggal).

Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Halaman ini memberikan informasi evaluasi kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh **dokter/bidan/perawat**

Kasus #1
Kunjungan ANC pertama di BPM, pada usia kehamilan 12 minggu
Ibu periksa ke Puskesmas pada usia kehamilan 14 minggu, sesuai anjuran bidan

Evaluasi Kesehatan Ibu Hamil

Diisi oleh Dokter

Nama Dokter: Indah Pratiwi Tanggal Periksa: 18 Pebruari 2026

Fasilitas Kesehatan: Puskesmas Kebon Jeruk

Kondisi Kesehatan Ibu

		IMT (BB (kg) / TB (m²))			
		Kurus < 18,5	Normal 18,5 – 24,9	Gemuk 25,0 – 29,9	Obesitas ≥ 30,0
TB	155 cm				
BB	59 kg		24,6		
LiLa	28 cm				

Status Imunisasi TD

Isi tanda ceklis (✓) pada status T terakhir

TT	Selang Waktu	Perlindungan	✓	Tgl/bln/thn
1		Awal	✓	th 2005
2	1 bulan	3 tahun	✓	th 2008
3	6 bulan	5 tahun	✓	th 2021
4	12 bulan	10 tahun	✓	th 2021
5	12 bulan	> 25 tahun		

Kesimpulan: Status imunisasi Imunisasi lainnya: COVID-19/ th 2021

Riwayat Kesehatan Ibu Sekarang

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
HIV	Lainnya:

Lingkari pilihanyang sesuai.

Riwayat Perilaku Berisiko 1 Bulan Sebelum Hamil

Aktivitas fisik kurang	Alkohol
Kosmetik yang mengandung zat berbahaya	Merokok
Obat Teratogenik	Pola makan berisiko
Lainnya: Tidak ada	

Lingkari pilihanyang sesuai.

Pemeriksaan Khusus

Inspeksi/ Inspekulo	Porsio	Normal	Tidak normal
	Uretra	Normal	Tidak normal
	Vagina	Normal	Tidak normal
	Vulva	Normal	Tidak normal
	Fluksus	+ / - -	+ / - -
	Fluor	+ / - -	+ / - -

Lingkari pilihanyang sesuai.

Riwayat Penyakit Keluarga

Alergi	Asma
Autoimun	Diabetes
Hepatitis B	Hipertensi ayah
Jantung	Jiwa
Sifilis	TB
HIV	Lainnya:

Lingkari pilihanyang sesuai.

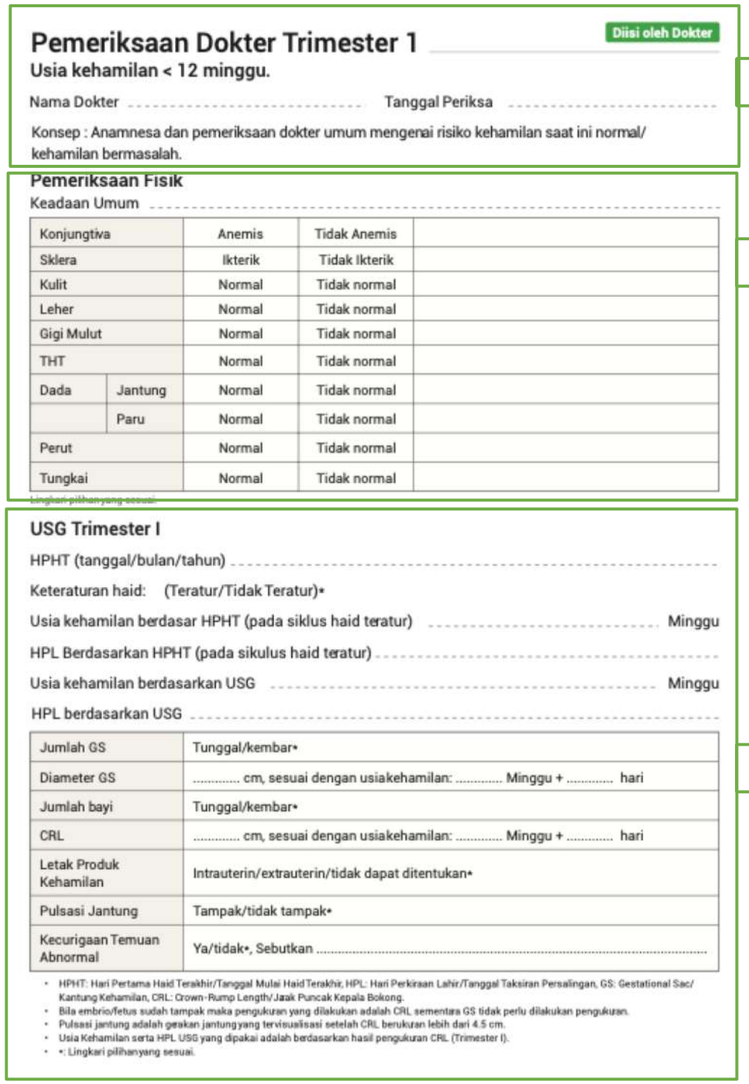
Riwayat Kehamilan dan Proses Melahirkan

Termasuk keguguran, kembar, dan lahir mati.

No	Tahun	BB gram	Proses Melahirkan	Penolong Proses Melahirkan	Masalah
1	2021	2800g	Spontan	Bidan, Puskesmas	tidak ada
2	hamil ini				
3					

Pemeriksaan Dokter Trimester 1

Halaman ini berisi informasi hasil pemeriksaan ibu hamil saat trimester 1 oleh **dokter**



Pemeriksaan Dokter Trimester 1

Diisi oleh Dokter

Usia kehamilan < 12 minggu.

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum .....

Konjungtiva		Anemis	Tidak Anemis	
Sklera		Ikterik	Tidak Ikterik	
Kulit		Normal	Tidak normal	
Leher		Normal	Tidak normal	
Gigi Mulut		Normal	Tidak normal	
THT		Normal	Tidak normal	
Dada	Jantung	Normal	Tidak normal	
	Paru	Normal	Tidak normal	
Perut		Normal	Tidak normal	
Tungkai		Normal	Tidak normal	

~~Lingkari pilihanyang sesuai~~

USG Trimester I

HPHT (tanggal/bulan/tahun) .....

Keteraturan haid: (Teratur/Tidak Teratur)*

Usia kehamilan berdasar HPHT (pada siklus haid teratur) ..... Minggu

HPL Berdasarkan HPHT (pada sikulus haid teratur) .....

Usia kehamilan berdasarkan USG ..... Minggu

HPL berdasarkan USG .....

Jumlah GS	Tunggal/kembar*
Diameter GS	..... cm, sesuai dengan usiakehamilan: ..... Minggu + ... hari
Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
CRL	..... cm, sesuai dengan usiakehamilan: ..... Minggu + ... hari
Letak Produk Kehamilan	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan*
Pulsasi Jantung	Tampak/tidak tampak*
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan .....

- HPHT: Hari Pertama Haid Terakhir/Tanggal Mulai Haid Terakhir, HPL: Hari Perkiraan Lahir/Tanggal Taksiran Persalingan, GS: Gestational Sac/ Kantung Kehamilan, CRL: Crown-Rump Length/ Jaak Puncak Kepala Bokong.
- Bila embrio/fetus sudah tampak maka pengukuran yang dilakukan adalah CRL sementara GS tidak perlu dilakukan pengukuran.
- Pulsasi jantung adalah gerakan jantung yang tervisualisasi setelah CRL berukuran lebih dari 4.5 cm.
- Usia Kehamilan serta HPL USG yang dipakai adalah berdasarkan hasil pengukuran CRL (Trimester I).
- *: Lingkari pilihanyang sesuai.

Dokter mengisi nama dan tanggal periksa

Dokter mengisi:

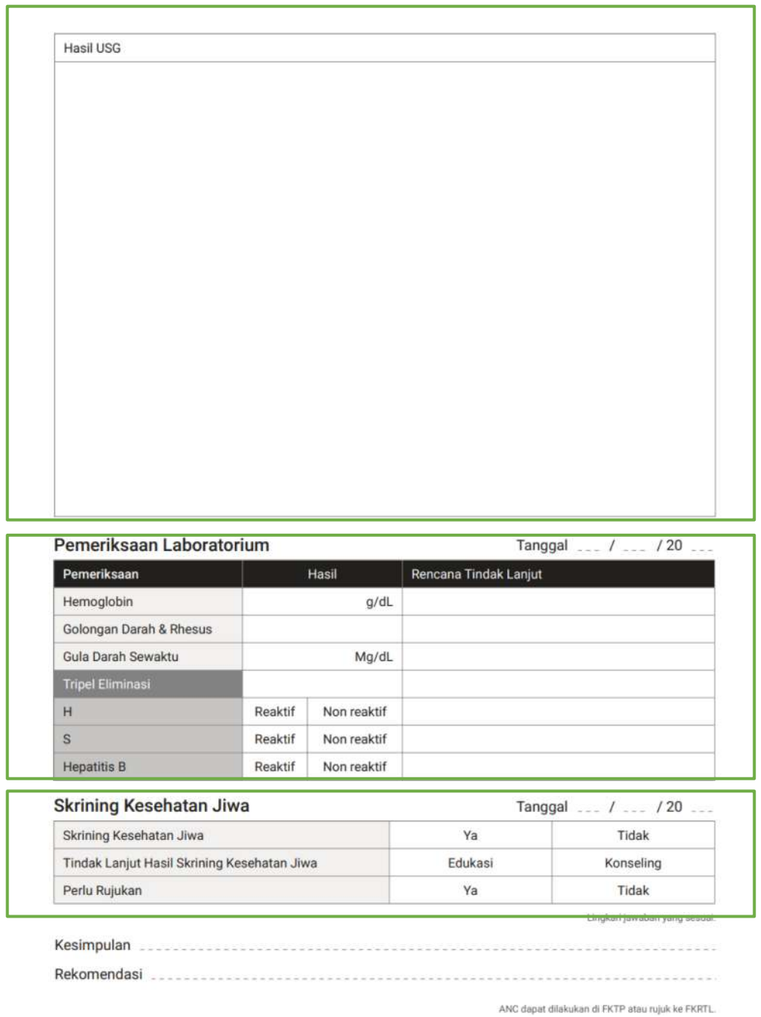
1. Keadaan umum ibu: baik / lemah / berdasarkan tingkat kesadaran ibu
2. Hasil pemeriksaan fisik **dilingkari** sesuai keadaan ibu saat itu.
3. Jika ada abnormalitas atau catatan keterangan lain, dapat ditulis di kolom kosong sebelahnya

Dokter mengisi data berdasarkan hasil pemeriksaan USG Trimester I:

1. HPHT: hari pertama haid terakhir / tanggal mulai haid terakhir diisi tanggal/bulan/tahun
2. Keteraturan haid, dilingkari pilihan sesuai kondisi ibu
3. Taksiran usia kehamilan berdasarkan HPHT
4. Taksiran HPL (Hari Perkiraan Lahir) berdasarkan HPHT
5. Usia kehamilan berdasarkan hasil pemeriksaan USG
6. Hari perkiraan lahir berdasarkan pemeriksaan USG
7. Jumlah kantung kehamilan / gestational sac (GS): : tunggal/kembar, lingkari salah satu
8. Diameter kantung kehamilan / gestational sac (GS)
9. Jumlah bayi: : tunggal/kembar, lingkari salah satu
10. Jarak puncak Kepala-bokong / Crown Rump Length (CRL)
11. Letak produk kehamilan/bayi: intrauterine/extrauterine/tidak dapat ditentukan, lingkari salah satu
12. Pulsasi jantung: tampak/tidak tampak, lingkari salah satu
13. Kecurigaan temuan abnormal: ya/tidak, lingkari salah satu. Jika ada, sebutkan

Pemeriksaan Dokter Trimester 1

Halaman ini berisi informasi hasil pemeriksaan ibu hamil saat trimester 1 oleh **dokter**



Hasil USG

Pemeriksaan Laboratorium Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Pemeriksaan	Hasil		Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin		g/dL	
Golongan Darah & Rhesus			
Gula Darah Sewaktu		Mg/dL	
Tripel Eliminasi			
H	Reaktif	Non reaktif	
S	Reaktif	Non reaktif	
Hepatitis B	Reaktif	Non reaktif	

Skrining Kesehatan Jiwa Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Lingkari jawaban yang sesuai.

Kesimpulan .....

Rekomendasi .....

ANC dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL.

Dokter menempelkan foto hasil USG TM I pada kolom ini

Dokter mengisi tabel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium:

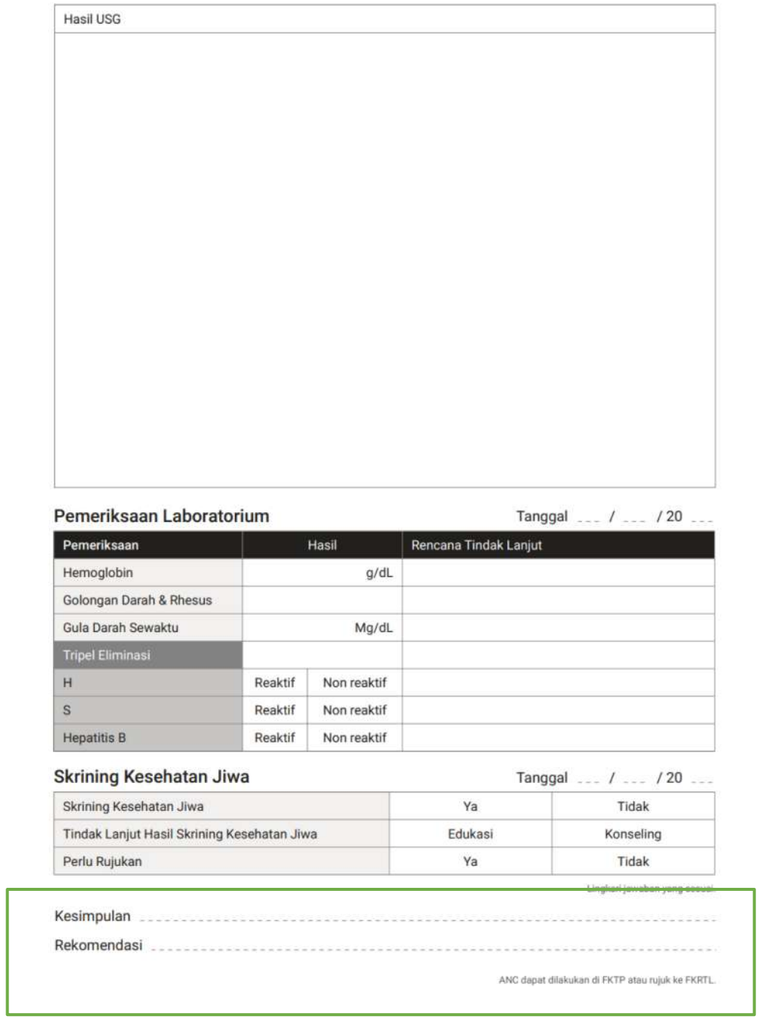
1. Mengisi pada kolom Hb; golongan darah dan rhesus; serta GDS sesuai hasil pemeriksaan.
2. Melingkari hasil pemeriksaan triple eliminasi (HIV, Sifilis, Hepatitis B) sesuai hasil pemeriksaan
3. Mengisi kolom tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. **Misal** ibu hamil ditemukan **anemia ringan** dengan Hb 10,5 gr/dl, maka pada kolom **tindak lanjut** diisi “Anemia ringan: pemberian TTD 1 tab + MMS 1 tab selama 4 minggu mulai tanggal 1 Februari 2025, ibu kembali ke faskes untuk dievaluasi pada tanggal 1 Maret 2025”

Dokter mengisi tabel skrining kesehatan jiwa:

1. Tanggal saat dilakukan skrining
2. Kolom “skrining kesehatan jiwa”: dilingkari “**ya”** jika dilakukan skrining dan **“tidak”** jika tidak dilakukan skrining
3. Kolom “tindak lanjut hasil skrining kesehatan jiwa”: dilingkari sesuai hasil skrining apakah butuh edukasi atau konseling sesuai hasil skrining.
4. Kolom “perlu rujukan”: dilingkari “**ya”** jika membutuhkan rujukan dan **“tidak”** jika tidak perlu rujukan sesuai hasil skrining.

Pemeriksaan Dokter Trimester 1

Halaman ini berisi informasi hasil pemeriksaan ibu hamil saat trimester 1 oleh **dokter**



Hasil USG

Pemeriksaan Laboratorium Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Pemeriksaan	Hasil		Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin		g/dL	
Golongan Darah & Rhesus			
Gula Darah Sewaktu		Mg/dL	
Tripel Eliminasi			
H	Reaktif	Non reaktif	
S	Reaktif	Non reaktif	
Hepatitis B	Reaktif	Non reaktif	

Skrining Kesehatan Jiwa Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Lingkari jawaban yang sesuai

Kesimpulan .....

Rekomendasi .....

ANC dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL.

Dokter mengisi tabel kesimpulan dengan:

1. G-P-A hamil …… minggu
2. Kehamilan normal atau ada komplikasi
3. Didapatkan masalah kesehatan: …… (sebutkan misal anemia, KEK, obesitas, preeklamsi, TB paru, dll)

Dokter mengisi tabel rekomendasi berdasarkan kesimpulan, dengan penjelasan:

1. ANC dapat dilakukan di FKTP, atau
2. Konsultasi ke dokter spesialis (sesuai kondisi ibu), atau
3. Rujuk ke FKRTL

Pemeriksaan Dokter Trimester 1

Diisi oleh Dokter

Usia kehamilan < 12 minggu.

Nama Dokter Indah Pratiwi Tanggal Periksa 18 Pebruari 2026

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasa

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum baik

Konjungtiva		Anemis	Tidak Anemis	
Sklera		Ikterik	Tidak Ikterik	
Kulit		Normal	Tidak normal	
Leher		Normal	Tidak normal	
Gigi Mulut		Normal	Tidak normal	GR 5| konsul Gilut
THT		Normal	Tidak normal	
Dada	Jantung	Normal	Tidak normal	
	Paru	Normal	Tidak normal	
Perut		Normal	Tidak normal	
Tungkai		Normal	Tidak normal	

Lingkari pilihan yang sesuai.

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 1

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali
	Keluhan saat ini Ringkas, fokus	

USG Trimester

HPHT (tanggal/bulan/tahun) 12 November 2025

Keteraturan haid: (Teratur/Tidak Teratur)*

Usia kehamilan berdasar HPHT (pada siklus haid teratur) 14 minggu ..... Minggu

HPL Berdasarkan HPHT (pada sikulus haid teratur) 19 Agustus 2026

Usia kehamilan berdasarkan USG 14 minggu + 2hari ..... Minggu

HPL berdasarkan USG 17 Agustus 2026

Jumlah GS	Tunggal/M
Diameter GS	..... cm, sesuai dengan usiakehamilan: ..... Minggu + ... hari
Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
CRL	8,1 ..... cm, sesuai dengan usiakehamilan: 14 M ..... hari
Letak Produk Kehamilan	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan
Pulsasi Jantung	Tampak/tidak tampak* 156 dpm
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan .....

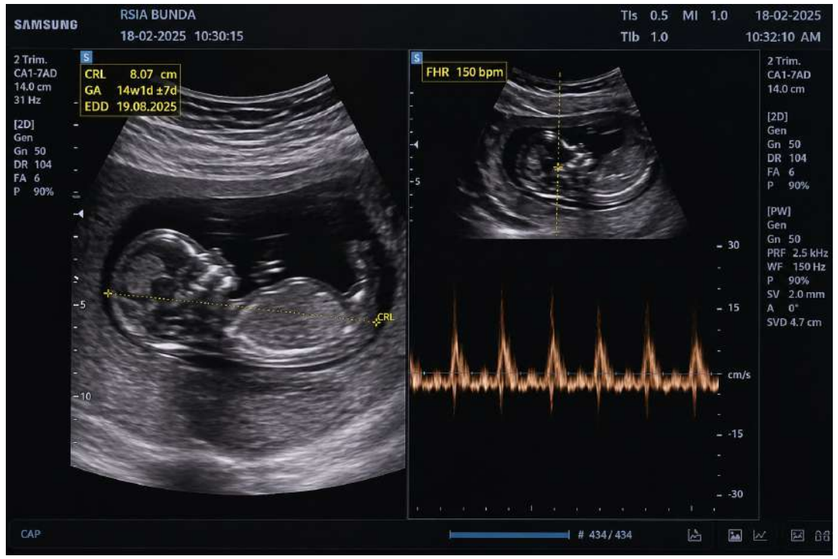
- HPHT: Hari Pertama Haid Terakhir/Tanggal Mulai Haid Terakhir, HPL: Hari Perkiraan Lahir/Tanggal Taksiran Persalinan, GS: Gestational Sac/ Kantung Kehamilan, CRL: Crown-Rump Length/Jarak Puncak Kepala Bokong.
- Bila embrio/fetus sudah tampak maka pengukuran yang dilakukan adalah CRL sementara GS tidak perlu dilakukan pengukuran.
- Pulsasi jantung adalah geakan jantung yang tervisualisasi setelah CRL berukuran lebih dari 4.5 cm.
- Usia Kehamilan serta HPL USG yang dipakai adalah berdasarkan hasil pengukuran CRL (Trimester I).
- *: Lingkari pilihan yang sesuai.

Kasus #1

Kunjungan ANC pertama di BPM, pada usia kehamilan 12 minggu

Ibu periksa ke Puskesmas pada usia kehamilan 14 minggu, sesuai anjuran bidan

Hasil USG



Kasus #1

Kunjungan ANC pertama di BPM, pada usia kehamilan 12 minggu

Ibu periksa ke Puskesmas pada usia kehamilan 14 minggu, sesuai anjuran bidan

USG Trimester I

HPHT (tanggal/bulan/tahun) 12 November 2025

Keterauran haid: (Teratur/Tidak Teratur)•

Usia kehamilan berdasar HPHT (pada siklus haid teratur) 14 minggu ..... Minggu

HPL Berdasarkan HPHT (pada sikulus haid teratur) 19 Agustus 2026

Usia kehamilan berdasarkan USG 14 minggu + 2hari ..... Minggu

HPL berdasarkan USG 17 Agustus 2026

Jumlah GS	Tunggal/k
Diameter GS	..... cm, sesuai dengan usiakehamilan: ..... Minggu + ... hari
Jumlah bayi	Tunggal/kembar•
CRL	8,1 ..... cm, sesuai dengan usiakehamilan: 14 ..... hari
Letak Produk Kehamilan	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan
Pulsasi Jantung	Tampak/tidak tampak• 156 dpm
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak•, sebutkan .....

- HPHT: Hari Pertama Haid Terakhir/Tanggal Mulai Haid Terakhir, HPL: Hari Perkiraan Lahir/Tanggal Taksiran Persalingan, GS: Gestational Sac/ Kantung Kehamilan, CRL: Crown-Rump Length/Jarak Puncak Kepala Bokong.
- Bila embrio/fetus sudah tampak maka pengukuran yang dilakukan adalah CRL sementara GS tidak perlu dilakukan pengukuran.
- Pulsasi jantung adalah gerakan jantung yang tervisualisasi setelah CRL berukuran lebih dari 4.5 cm.
- Usia Kehamilan serta HPL USG yang dipakai adalah berdasarkan hasil pengukuran CRL (Trimester I).
- •: Lingkari pilihanyang sesuai.

Pemeriksaan Laboratorium

Tanggal 18 Pebruari 2026

Pemeriksaan	Hasil		Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	11,3 g/dL		MMS 1x1 ATAU TTD 1x1
Golongan Darah & Rhesus	A+		
Gula Darah Sewaktu	135 Mg/dL		
Tripel Eliminasi			
H	Reaktif	Non reaktif	
S	Reaktif	Non reaktif	
Hepatitis B	Reaktif	Non reaktif	

Skrining Kesehatan Jiwa

Tanggal 18 Pebruari 2026

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Lingkari jawaban yang sesuai.

Kesimpulan G2P1 Hamil 14 minggu Janin Tunggal hidup, kehamilan tanpa komplikasi dengan GR – konsultasi Gilut

Rekomendasi ANC dapat dilakukan di FPKTP

ANC dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL

Pemeriksaan Dokter Trimester 1 (contoh kasus #2)

Pemeriksaan Laboratorium

Tanggal 10 / 02 / 26

Pemeriksaan	Hasil		Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	10,3	g/dL	Uji defisiensi besi – TTD 2x1 selama 4 minggu, cek ulang Hb
Golongan Darah & Rhesus	A+		
Gula Darah Sewaktu	115	Mg/dL	
Tripel Eliminasi			
H	Reaktif	Non reaktif	
S	Reaktif	Non reaktif	
Hepatitis B	Reaktif	Non reaktif	

Kesimpulan: G3P2 hamil 12 minggu dengan anemia ringan – TTD 2x1 selama 4 minggu

Rekomendasi: cek ulang Hb 4 minggu
ANC di FPKTP

ANC dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL

100 Lihat edukasi untuk ibu hamil pada masa trimester 1 di halaman 6-8.

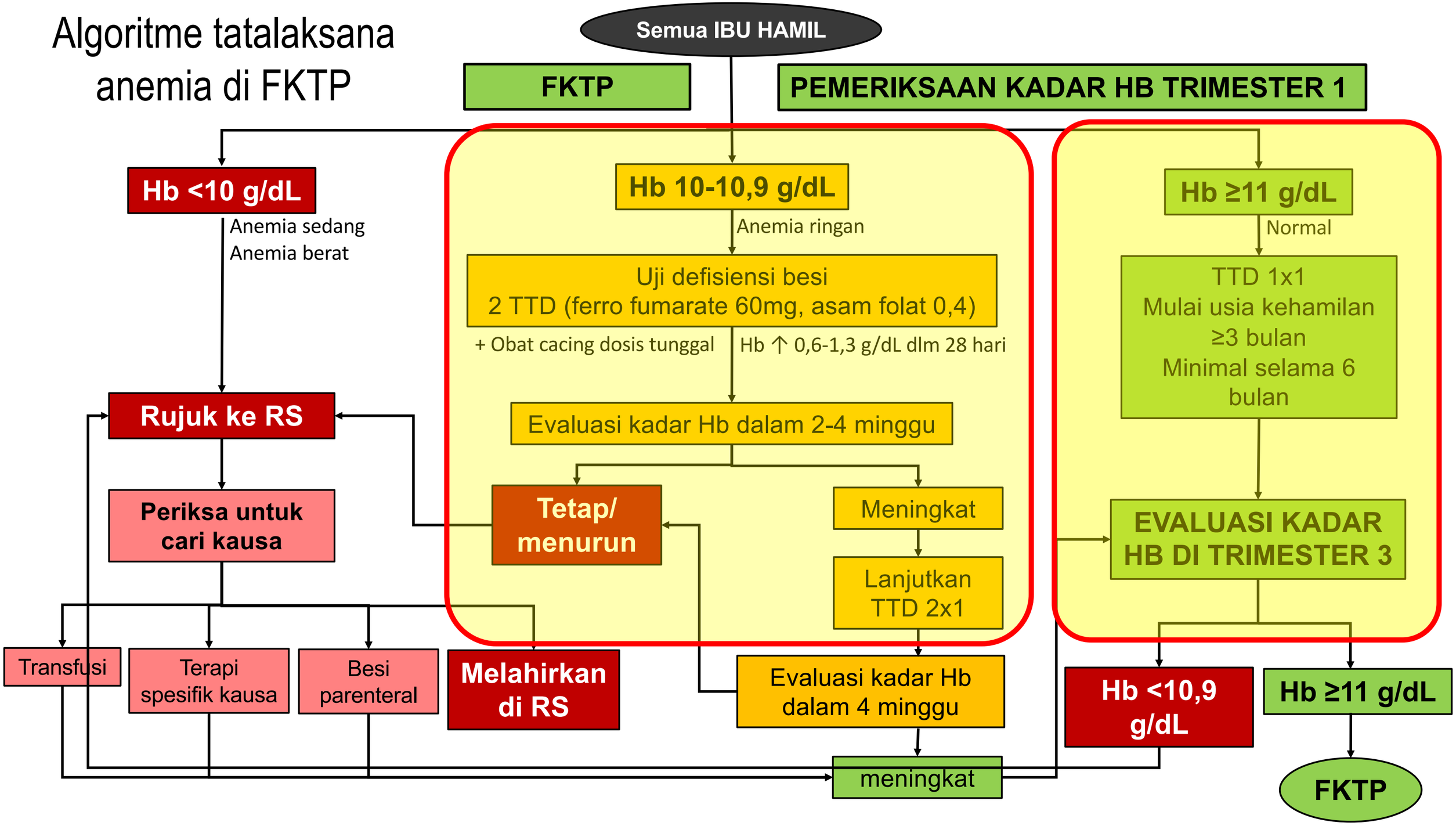
PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 1

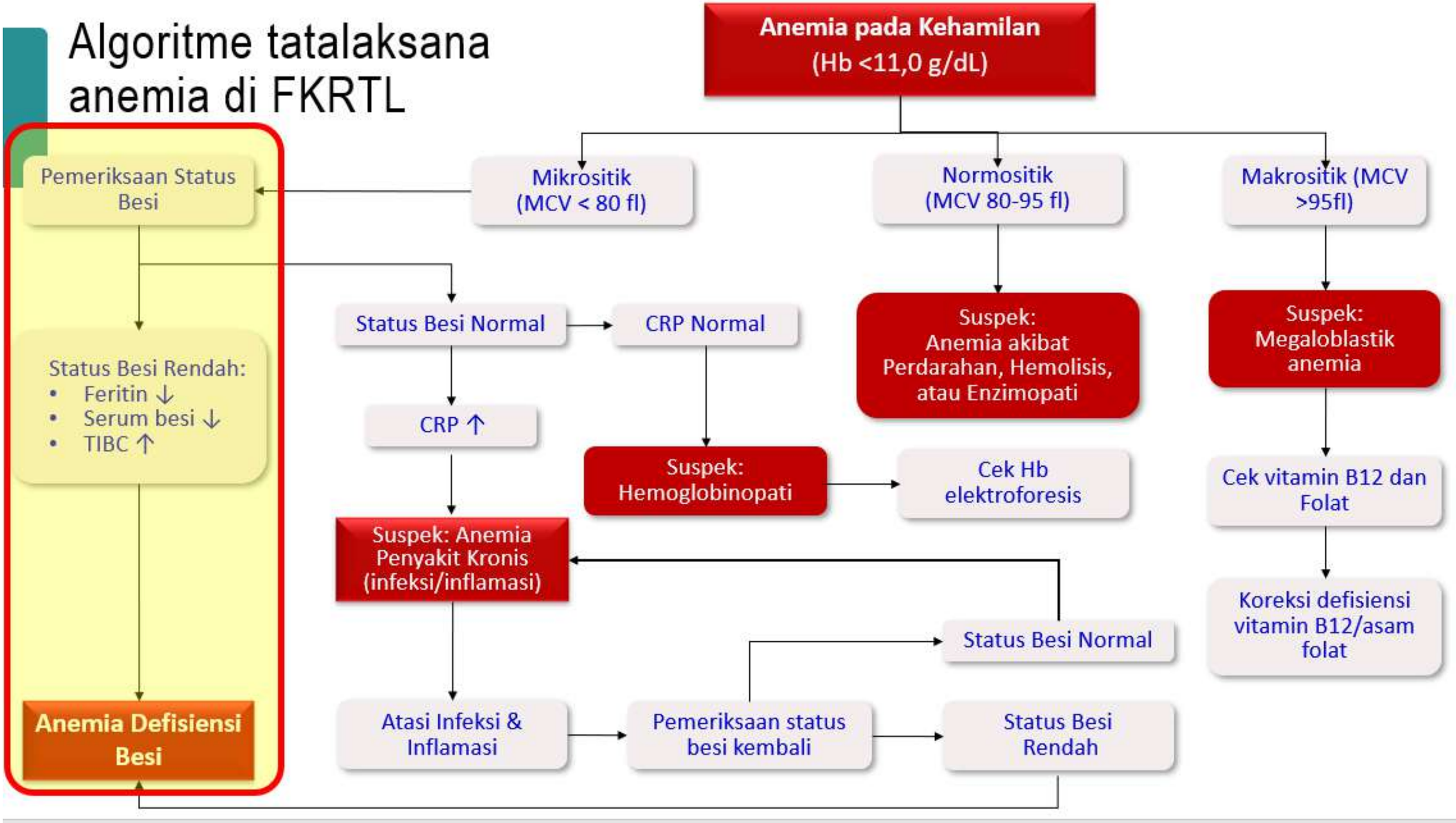
Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali
10/02/26	Anemia ringan, suspek defisiensi besi T/ TTD 2x1 utk 4 mgg Cek ulang Hb tgl 10/3	10/03/26
10/03/26	Cek Hb ulang 11,2 T/ lanjutkan TTD 2x – evaluasi Hb 4mgg	07/04/26

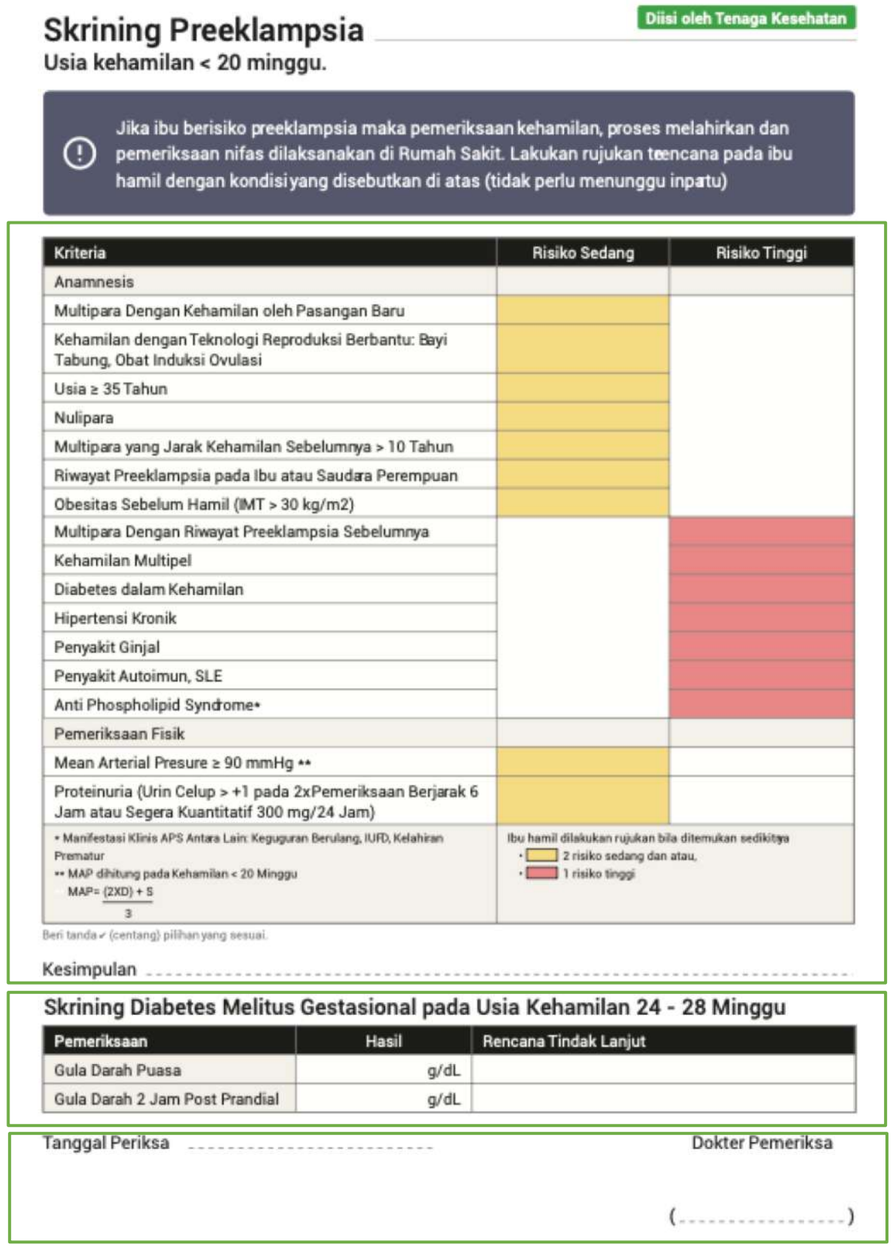
Algoritme tatalaksana anemia di FKTP



Algoritme tatalaksana anemia di FKRTL



Skrining Preeklampsia



Skrining Preeklampsia

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Usia kehamilan < 20 minggu.

Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan teencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inpartu)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru		
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantu: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi		
Usia ≥ 35 Tahun		
Nulipara		
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun		
Riwayat Preeklampsia pada Ibu atau Saudara Perempuan		
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m2)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		
Kehamilan Multipel		
Diabetes dalam Kehamilan		
Hipertensi Kronik		
Penyakit Ginjal		
Penyakit Autoimun, SLE		
Anti Phospholipid Syndrome*		
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Presure ≥ 90 mmHg **		
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2xPemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif 300 mg/24 Jam)		

* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, IUFD, Kelahiran Prematur

** MAP dihitung pada Kehamilan < 20 Minggu

$MAP = \frac{(2XD) + S}{3}$

Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitya
- 2 risiko sedang dan atau,
- 1 risiko tinggi

Beri tanda ✔ (centang) pilihan yang sesuai.

Kesimpulan .....

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

Tanggal Periksa .....

Dokter Pemeriksa

(.....)

1. **Tenaga kesehatan melakukan skrining** risiko preeklampsia pada semua ibu hamil saat kunjungan/kontak pertama (K1) atau paling lambat sebelum usia kehamilan 20 minggu
2. Hasil pemeriksaan diberikan tanda *checklist* (**V**) pada kriteria yang dialami ibu:
   a) jika didapati 2 tanda *checklist* (**V**) pada kotak kuning, dan/atau
   b) 1 tanda *checklist* (**V**) pada kotak merah maka **ibu berisiko mengalami preeklampsia dan segera lakukan rujukan**
3. **Tenaga kesehatan menghitung *Mean Arterial Pressure* (MAP).** Jika MAP ≥ 90 maka risiko preeklamsi meningkat dan lakukan rujukan. **MAP dihitung pada kehamilan < 20 minggu**
4. Pada bagian "Kesimpulan" **tenaga kesehatan mengisi** berdasarkan hasil skrining: apabila ibu berisiko preeklamsia maka pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit.
5. **Tenaga kesehatan** melakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang berisiko tersebut (tidak perlu menunggu inpartu).

Tenaga kesehatan melakukan skrining Diabetes Melitus Gestasional dengan pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam post prandial. Berdasarkan hasil pemeriksaan tsb, **tenaga kesehatan mengisi** kolom rencana tindak lanjut. Skrining ini dilakukan pada usia kehamilan 24 – 28 minggu (Trimester 2)

Tenaga kesehatan mengisi tanggal pemeriksaan dan dokter membubuhkan tanda tangan.

Skrining Preeklampsia

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Usia kehamilan < 20 minggu.

Jika ibu berisiko preeklampsia maka pemeriksaan kehamilan, proses melahirkan dan pemeriksaan nifas dilaksanakan di Rumah Sakit. Lakukan rujukan terencana pada ibu hamil dengan kondisi yang disebutkan di atas (tidak perlu menunggu inpartu)

Kriteria	Risiko Sedang	Risiko Tinggi
Anamnesis		
Multipara Dengan Kehamilan oleh Pasangan Baru	-	
Kehamilan dengan Teknologi Reproduksi Berbantu: Bayi Tabung, Obat Induksi Ovulasi	-	
Usia ≥ 35 Tahun	-	
Nulipara	-	
Multipara yang Jarak Kehamilan Sebelumnya > 10 Tahun	-	
Riwayat Preeklampsia pada Ibu atau Saudara Perempuan	-	
Obesitas Sebelum Hamil (IMT > 30 kg/m2)		
Multipara Dengan Riwayat Preeklampsia Sebelumnya		-
Kehamilan Multipel		-
Diabetes dalam Kehamilan		-
Hipertensi Kronik		-
Penyakit Ginjal		-
Penyakit Autoimun, SLE		-
Anti Phospholipid Syndrome*		-
Pemeriksaan Fisik		
Mean Arterial Presure ≥ 90 mmHg **	-	
Proteinuria (Urin Celup > +1 pada 2xPemeriksaan Berjarak 6 Jam atau Segera Kuantitatif 300 mg/24 Jam)	-	

* Manifestasi Klinis APS Antara Lain: Keguguran Berulang, IUFD, Kelahiran Prematur

** MAP dihitung pada Kehamilan < 20 Minggu

$MAP = \frac{(2XD) + S}{3}$

Ibu hamil dilakukan rujukan bila ditemukan sedikitnya
- 2 risiko sedang dan atau,
- 1 risiko tinggi

Beri tanda ✓ (centang) pilihan yang sesuai.

Kesimpulan Skrining preeklampsia NEGATIF

- Hasil terbaik jika skrining dilakukan pada usia kehamilan <16minggu
- Sebagian besar adalah berdasarkan anamnesis – riwayat kehamilan, penyakit
- Manifestasi APS, autoimun lain – dapat ditanyakan Riwayat keguguran berulang, IUFD, kelahiran prematur (akan dikonfirmasi di RS)
- Pemeriksaan fisik meliputi:

✓ Pengukuran MAP – >90mmHg

✓ Proteinuria – positif 1 pada 2x pemeriksaan berjarak 6 jam

- RS diharapkan menambahkan pemeriksaan skrining dengan Doppler a. uterine
- Ibu Risiko tinggi PE diberikan terapi pencegahan: aspirin dosis rendah dan kalsium dosis tinggi hingga UK 36 mgg

Skrining Diabetes Melitus Gestasional pada Usia Kehamilan 24 - 28 Minggu

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Gula Darah Puasa	g/dL	
Gula Darah 2 Jam Post Prandial	g/dL	

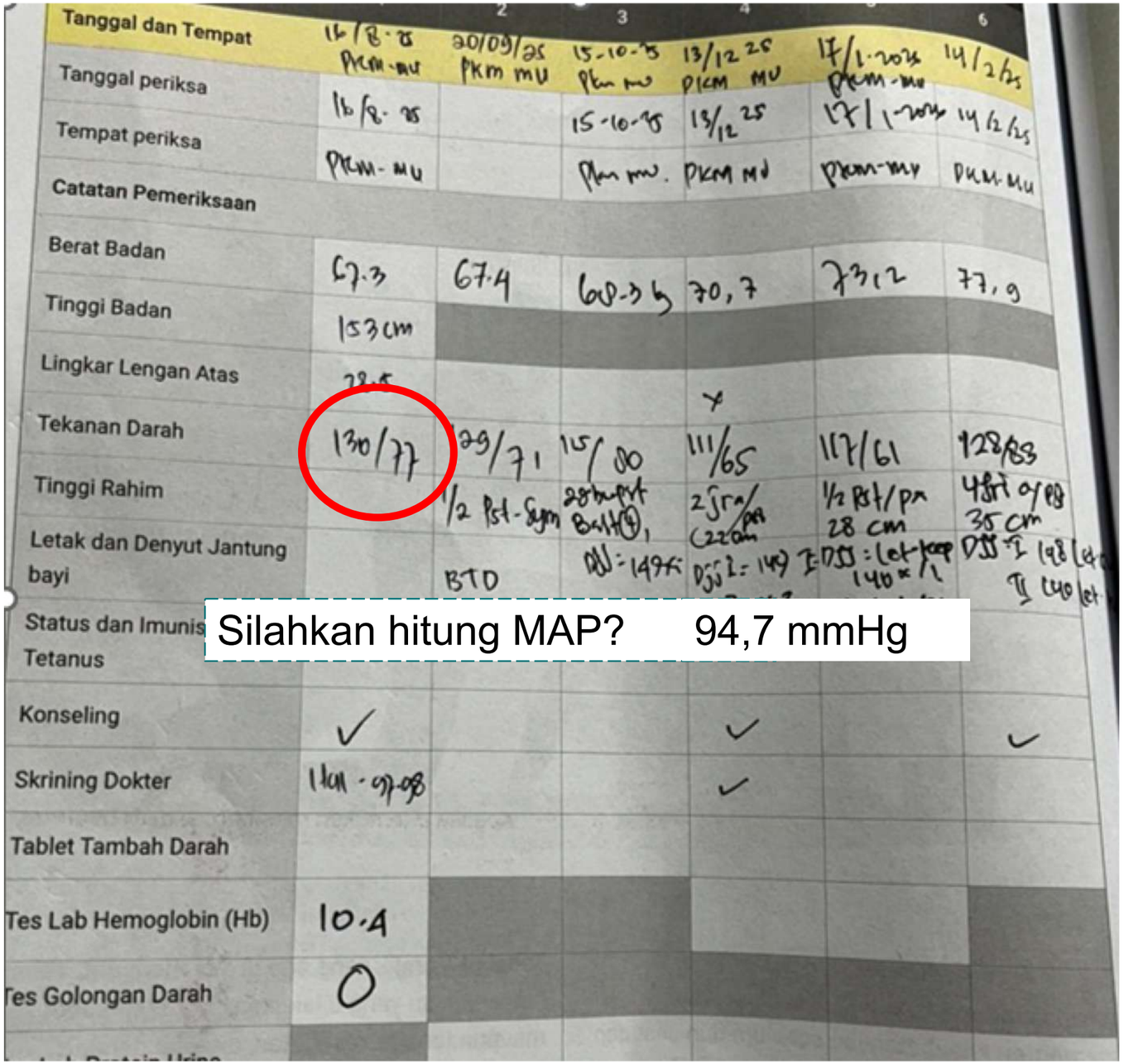
Tanggal Periksa .....

Dokter Pemeriksa

(dr Indah Pratiwi)

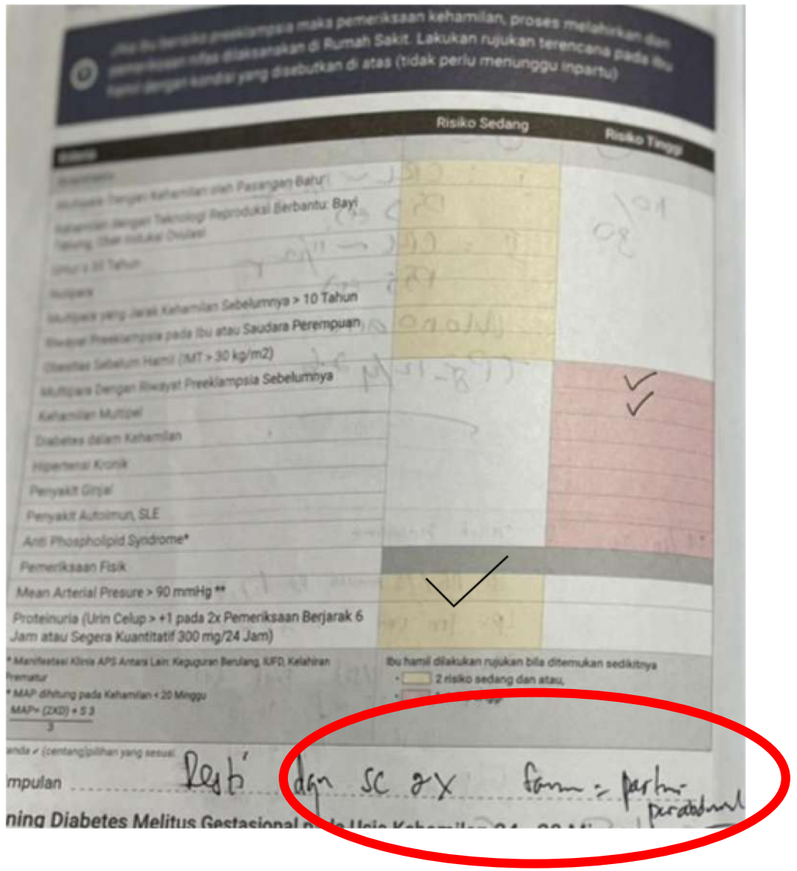
Kasus #3

Ny, 32 tahun G3P2 hamil 34 minggu
Janin Gemelli
Riwayat PE (2x)
BSC 2x

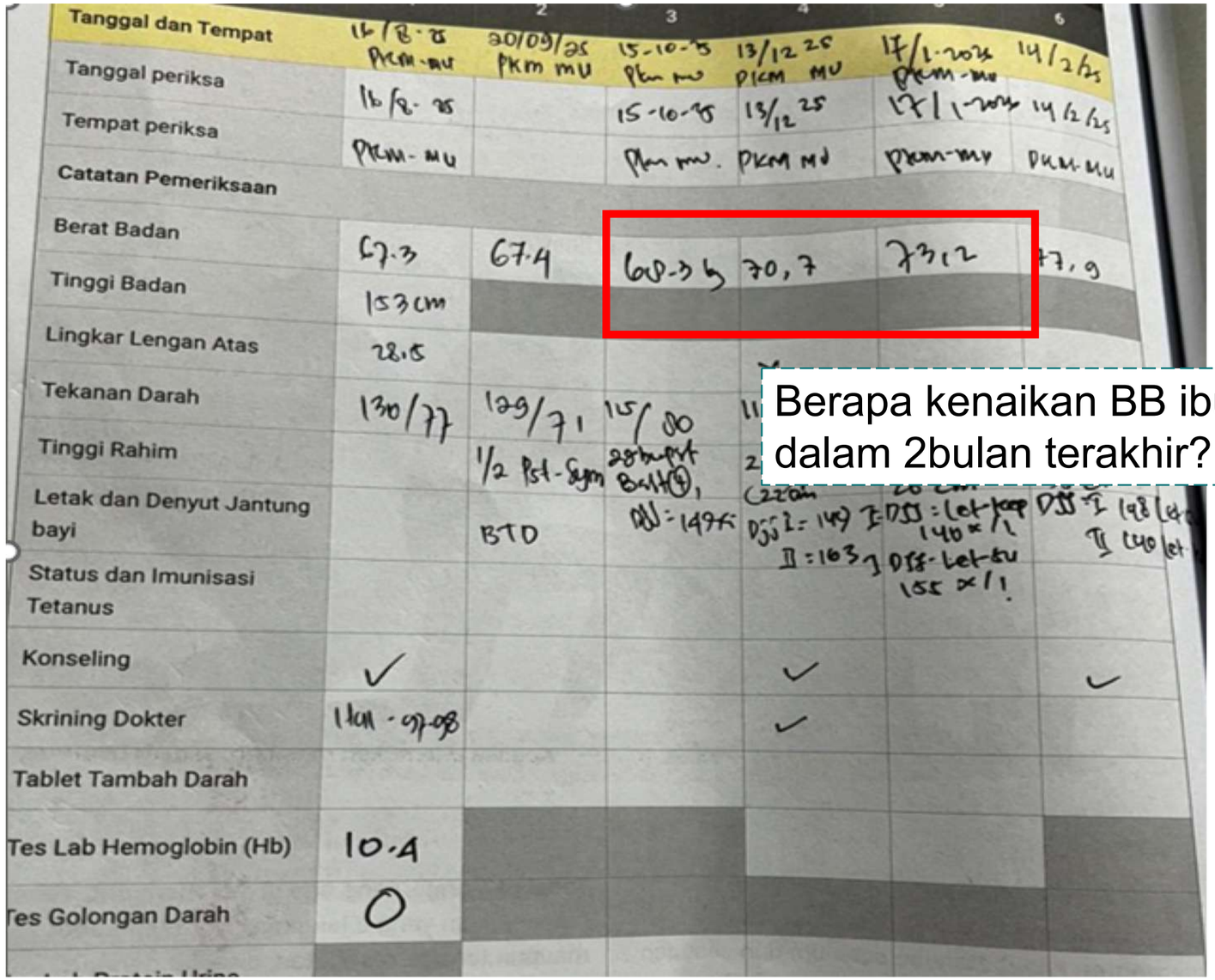


Tanggal dan Tempat	1	2	3	4	5	6
Tanggal periksa	16/8-25	20/09/25	15-10-25	13/12 25	17/1-2026	14/2/25
Tempat periksa	PKM-MU	PKM MU	PKM MU	PKM MU	PKM-MU	PKM-MU
Catatan Pemeriksaan						
Berat Badan	67.3	67.4	68-3	70,7	73,2	77,9
Tinggi Badan	153 cm					
Lingkar Lengan Atas						
Tekanan Darah	130/77	129/71	115/80	111/65	117/61	128/83
Tinggi Rahim		1/2 Pst-Sym	28 bulan Bulat	2 jr a/pr (220	1/2 Pst/pr 28 cm	4 jr a/pr 35 cm
Letak dan Denyut Jantung bayi		BTD	DJJ: 149x	DJJ 2: 149	DJJ: Let-kep 140 x/1	DJJ: I 138 Let-ka II 140 Let
Status dan Imunis Tetanus						
Konseling	✓			✓		✓
Skrining Dokter	1Kun - 07.08			✓		
Tablet Tambah Darah						
Tes Lab Hemoglobin (Hb)	10.4					
Tes Golongan Darah	O					

Silahkan hitung MAP? 94,7 mmHg



Kesimpulan: ibu dengan Risiko tinggi preeklampsia



Tanggal dan Tempat	1	2	3	4	5	6
Tanggal periksa	16/8-25 PKM-MU	30/09/25 PKM MU	15-10-25	13/12 25 PKM MU	17/1-2026	14/2/26
Tempat periksa	PKM-MU		PKM MU.	PKM MU	PKM-MU	PKM-MU
Catatan Pemeriksaan						
Berat Badan	57.3	67.4	60-3 kg	70,7	73,2	7,9
Tinggi Badan	153 cm					
Lingkar Lengan Atas	28.5					
Tekanan Darah	130/77	129/71	115/80			
Tinggi Rahim		1/2 Pst-Sym	28 bulan			
Letak dan Denyut Jantung bayi		BTD	DJJ: 149	I: DJJ: Let-kep 140 x/1 II: 163 DJJ-Let-ku 155 x/1		DJJ: I 148 II 140
Status dan Imunisasi Tetanus						
Konseling	✓			✓		✓
Skrining Dokter	1 kali - 07-08			✓		
Tablet Tambah Darah						
Tes Lab Hemoglobin (Hb)	10.4					
Tes Golongan Darah	O					

Berapa kenaikan BB ibu dalam 2bulan terakhir?

Pada kasus ini – apa penyebab kenaikan BB maternal yang tiba-tiba melonjak?

Pemeriksaan Dokter Trimester 3

Pemeriksaan Dokter Trimester 3

Diisi oleh Dokter

Umur kehamilan 32 - 36 minggu.

Nama Dokter ..... Tanggal Periksa .....

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum .....

Konjungtiva		Anemia	Tidak Anemia	
Sklera		Ikterik	Tidak Ikterik	
Kulit		Normal	Tidak normal	
Leher		Normal	Tidak normal	
Gigi Mulut		Normal	Tidak normal	
THT		Normal	Tidak normal	
Dada	Jantung	Normal	Tidak normal	
	Paru	Normal	Tidak normal	
Perut		Normal	Tidak normal	
Tungkai		Normal	Tidak normal	

USG Trimester III

USG Trimester III telah dilakukan: Ya/tidak*

- Bila ya, Umur Kehamilan saat ini berdasarkan USG Trimester I: ..... minggu.
- Bila tidak dan haid teratur, umur kehamilan saat ini berdasarkan HPHT: ..... minggu.

Umur Kehamilan berdasarkan biometri bayi USG Trimester III: ..... minggu.

Apakah terdapat selisih 3 minggu atau lebih diantara UK USG Trimester I/HPHT dengan UK USG Trimester III: Ya/tidak*

Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
Letak bayi	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan*
Presentasi bayi	Kepala/Bokong/Letak Lintang*
Keadaan bayi	Hidup/meninggal*, DJJ: ..... X/m (normal/tidak normal)*
Lokasi Plasenta	Fundus/corpus/letak rendah/previa*
Jumlah Cairan Ketuban	SDP: ..... cm, cukup/kurang/berlebih*
Biometri bayi	BPD: ..... cm, sesuai: ..... minggu HC: ..... cm, sesuai: ..... minggu AC: ..... cm, sesuai: ..... minggu FL: ..... cm, sesuai: ..... minggu EFW/TBJ: ..... gram, sesuai: ..... minggu
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan .....

- DJJ: Denyut Jantung bayi, SDP: Ujuran, BPD: Biparietal Diameter/jarak tuluang parietal kepala, HC: Head Circumference/lingkar dada, AG: Abdominal Circumference/lingkar perut, PL: Femur Length/panjang tulang paha, EFW: Estimates Fetal Weight, TBJ: Taksiran Berat bayi.
- *: Lingkari pilihan yang sesuai.

Dokter mengisi nama dan tanggal periksa

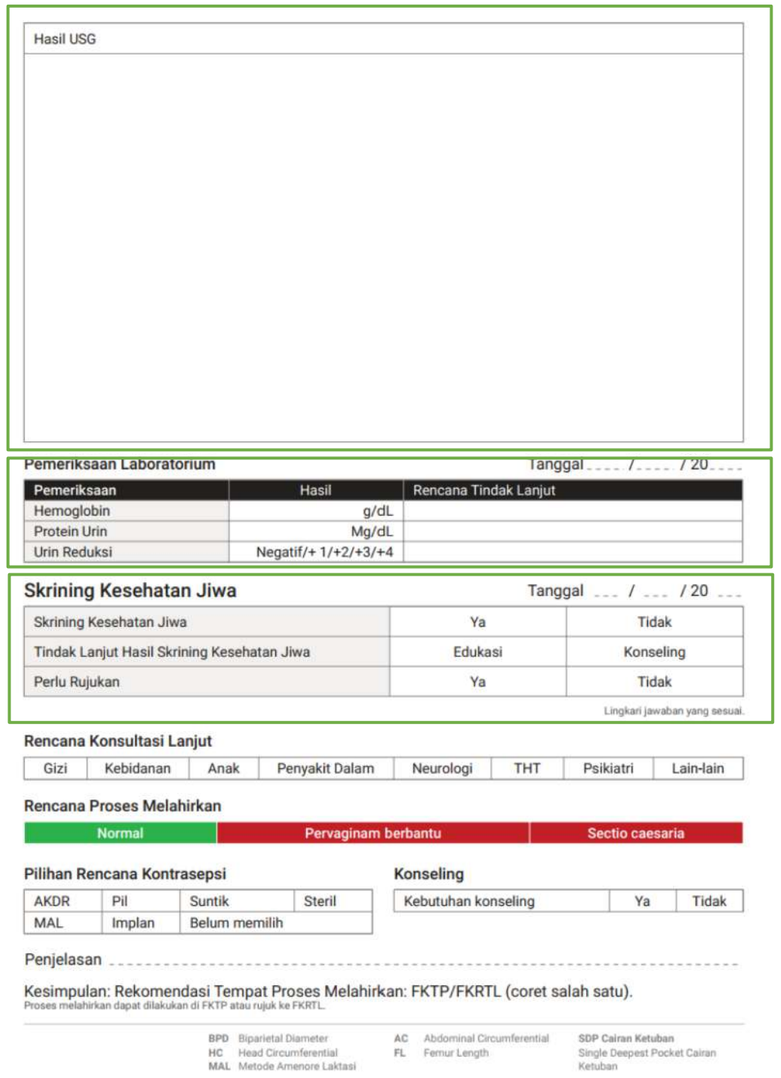
Dokter mengisi:

1. Keadaan umum ibu: baik / lemah / berdasarkan tingkat kesadaran ibu
2. Hasil pemeriksaan fisik **dilingkari** sesuai keadaan ibu saat itu.
3. Jika ada abnormalitas atau catatan keterangan lain, dapat ditulis di kolom kosong sebelahnya

Dokter mengisi data berdasarkan hasil pemeriksaan USG Trimester III:

1. USG TM III: lingkari “ya” jika telah dilakukan, atau “tidak” jika tidak dilakukan
2. Taksiran usia kehamilan berdasarkan hasil USG TM I
3. Jika tidak dilakukan USG TM I maka taksiran usia kehamilan dihitung berdasarakan HPHT
4. Taksiran usia kehamilan berdasarkan biometri bayi USG TM III
5. Hitung selisih antara taksiran usia kehamilan berdasarkan hasil USG TM I/HPHT dibanding taksiran usia kehamilan USG TM III, lingkari “ya” jika ada selisih ≥ 3 minggu atau lingkari “tidak” jika tidak ada selisih atau selisih < 3 minggu Jumlah kantung kehamilan / gestational sac (GS): lingkari salah satu
6. Jumlah bayi: tunggal/kembar, lingkari salah satu
7. Letak bayi: intrauterine/extrauterine/tidak dapat ditentukan, lingkari salah satu
8. Presentasi bayi: Kepala/bokong/letak lintang, lingkari salah satu
9. Keadaan bayi: hidup/meninggal, lingkari salah satu.
10. DJJ: diisi …….x/menit lalu lingkari apakah normal/tidak normal
11. Lokasi plasenta: fundus/corpus/letak rendah/previa, lingkari salah satu
12. Jumlah cairan ketuban: isi SDP berapa cm, lalu lingkari salah satu apakah cukup/kurang/berlebih
13. Biometri bayi: diisi informasi mengenai BPD, HC, AC, EFW/TBJ
14. Kecurigaan temuan abnormal: ya atau tidak, lingkari salah satu. Jika “ya” maka sebutkan abnormalitas yang ditemukan

Pemeriksaan Dokter Trimester 3



Hasil USG

Pemeriksaan Laboratorium Tanggal ___ / ___ / 20___

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	g/dL	
Protein Urin	Mg/dL	
Urin Reduksi	Negatif/+ 1/+2/+3/+4	

Skrining Kesehatan Jiwa Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Lingkari jawaban yang sesuai.

Rencana Konsultasi Lanjut

Gizi	Kebidanan	Anak	Penyakit Dalam	Neurologi	THT	Psikiatri	Lain-lain

Rencana Proses Melahirkan

Normal	Pervaginam berbantu	Sectio caesaria

Pilihan Rencana Kontrasepsi

AKDR	Pil	Suntik	Steril
MAL	Implan	Belum memilih	

Konseling

Kebutuhan konseling	Ya	Tidak

Penjelasan ---

Kesimpulan: Rekomendasi Tempat Proses Melahirkan: FKTP/FKRTL (coret salah satu).
Proses melahirkan dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL.

BPD Biparietal Diameter
HC Head Circumferential
MAL Metode Amenore Laktasi
AC Abdominal Circumferential
FL Femur Length
SDP Cairan Ketuban Single Deepest Pocket Cairan Ketuban

Dokter menempelkan foto hasil USG TM III pada kolom ini

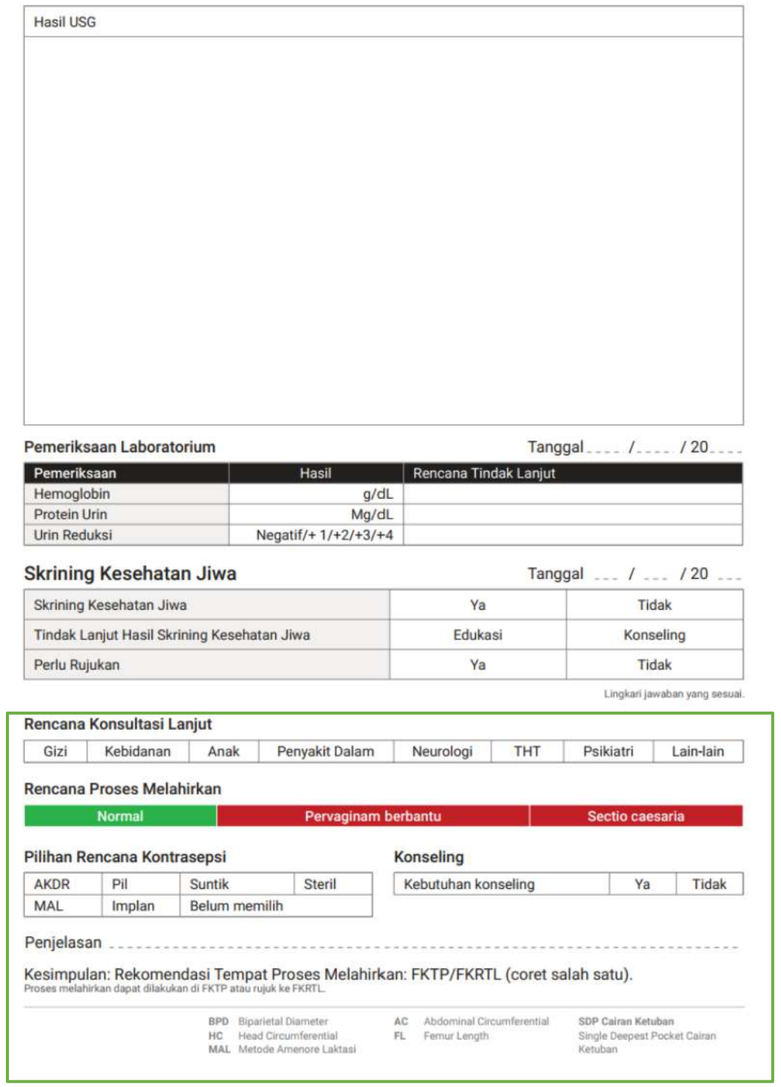
Dokter mengisi tabel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium:

1. Mengisi pada kolom Hb; protein urine dan urine reduksi sesuai hasil pemeriksaan.
2. Mengisi kolom tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti

Dokter mengisi tabel skrining kesehatan jiwa:

1. Tanggal saat dilakukan skrining
2. Kolom “skrining kesehatan jiwa”: dilingkari “**ya”** jika dilakukan skrining dan **“tidak”** jika tidak dilakukan skrining
3. Kolom “tindak lanjut hasil skrining kesehatan jiwa”: dilingkari sesuai hasil skrining apakah butuh edukasi atau konseling sesuai hasil skrining.
4. Kolom “perlu rujukan”: dilingkari “**ya”** jika membutuhkan rujukan dan **“tidak”** jika tidak perlu rujukan sesuai hasil skrining.

Pemeriksaan Dokter Trimester 3



Hasil USG

Pemeriksaan Laboratorium Tanggal ___ / ___ / 20___

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	g/dL	
Protein Urin	Mg/dL	
Urin Reduksi	Negatif/+ 1/+2/+3/+4	

Skrining Kesehatan Jiwa Tanggal ___ / ___ / 20 ___

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Lingkari jawaban yang sesuai.

Rencana Konsultasi Lanjut

Gizi	Kebidanan	Anak	Penyakit Dalam	Neurologi	THT	Psikiatri	Lain-lain

Rencana Proses Melahirkan

Normal	Pervaginam berbantu	Sectio caesaria

Pilihan Rencana Kontrasepsi

AKDR	Pil	Suntik	Steril
MAL	Implan	Belum memilih	

Konseling

Kebutuhan konseling	Ya	Tidak

Penjelasan _____

Kesimpulan: Rekomendasi Tempat Proses Melahirkan: FKTP/FKRTL (coret salah satu).
Proses melahirkan dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL.

BPD Biparietal Diameter
HC Head Circumferential
MAL Metode Amenore Laktasi
AC Abdominal Circumferential
FL Femur Length
SDP Cairan Ketuban Single Deepest Pocket Cairan Ketuban

1. **Dokter melingkari salah satu atau lebih** rencana konsultasi lanjut kepada spesialis sesuai hasil pemeriksaan saat TM III jika diperlukan, sesuai kondisi ibu.
2. **Dokter melingkari salah satu pilihan rencana persalinan** berdasarkan hasil pemeriksaan: normal/pervaginam berbantu/SC. Apabila hasil pemeriksaan ada di **zona merah** maka ibu harus melahirkan di FKRTL.
3. **Dokter / tenaga kesehatan mengisi pilihan rencana kontrasepsi** ibu (jika ibu telah menentukan).
4. **Tenaga kesehatan melingkari salah satu pilihan** apakah ibu membutuhkan **konseling lanjutan** misalkan mengenai pilihan berKB jika ibu masih belum menentukan.
5. **Dokter mengisi penjelasan** jika ada keterangan/penjelasan tambahan yang perlu untuk dicatat sesuai hasil pemeriksaan pada TM III.
6. **Dokter mengisi kesimpulan dan rekomendasi** tempat persalinan dapat dilakukan di FKTP/FKRTL, **coret yang tidak diperlukan**.
   Jika diperlukan, beri catatan bahwa ibu hamil dapat melakukan konsultasi ke dokter spesialis untuk menentukan tempat persalinan.
   Pada bagian ini, sebelum menentukan rekomendasi, dokter juga bisa menambahkan catatan :
   - G-P-A- hamil….minggu
   - tidak didapatkan penyulit pada kehamilan saat ini, atau
   - didapatkan masalah kesehatan/komplikasi: …… (sebutkan)

Pemeriksaan Dok[illegible] Trimester 3

Diisi oleh Dokter

Umur kehamilan 32 - [illegible] minggu.

Nama Dokter In[illegible] ratiwi Tanggal Periksa 24 Juni 2026

Konsep : Anamnesa dan pemeriksaan dokter umum mengenai risiko kehamilan saat ini normal/ kehamilan bermasalah.

Pemeriksaan Fisik

Keadaan Umum baik

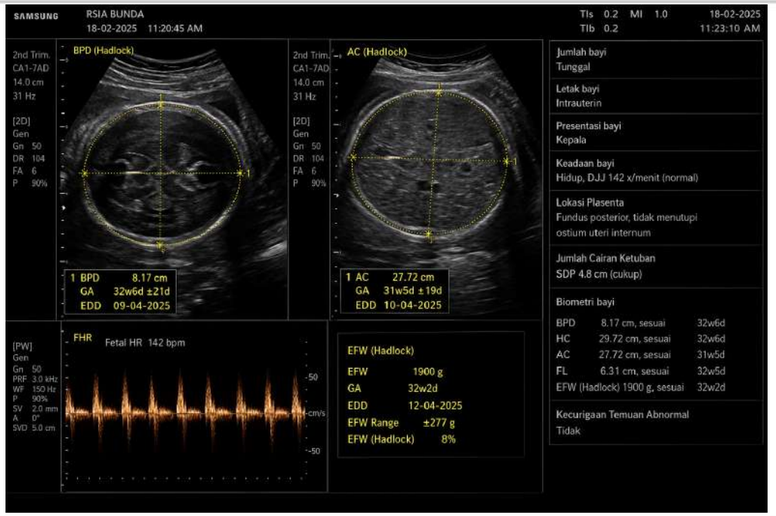
Konjungtiva		Anemia	Tidak Anemia	
Sklera		Ikterik	Tidak Ikterik	
Kulit		Normal	Tidak normal	
Leher		Normal	Tidak normal	
Gigi Mulut		Normal	Tidak normal	
THT		Normal	Tidak normal	
Dada	Jantung	Normal	Tidak normal	
	Paru	Normal	Tidak normal	
Perut		Normal	Tidak normal	
Tungkai		Normal	Tidak normal	

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 3

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

Hasil USG



USG Trimester III

USG Trimester III telah dilakukan: Ya/tidak*

- Bila ya, Umur Kehamilan saat ini berdasarkan USG Trimester I: 32 ..... minggu.
- Bila tidak dan haid teratur, umur kehamilan saat ini berdasarkan HPHT: 32 ..... minggu.

Umur Kehamilan berdasarkan biometri bayi USG Trimester III: 32 ..... minggu.

Apakah terdapat selisih 3 minggu atau lebih diantara UK USG Trimester I/HPHT dengan UK USG Trimester III: Ya/tidak*

Jumlah bayi	Tunggal/kembar*
Letak bayi	Intrauterin/extrauterin/tidak dapat ditentukan*
Presentasi bayi	Kepala/Bokong/Letak Lintang*
Keadaan bayi	Hidup/meninggal*, DJJ: 142 x/m (normal/tidak normal)*
Lokasi Plasenta	Fundus/corpus/letak rendah/previa*
Jumlah Cairan Ketuban	SDP: 4,8 cm, cukup/kurang/berlebih*
Biometri bayi	BPD: 8,17 cm, sesuai: 32+2 minggu HC: 29,72 cm, sesuai: 32+2 minggu AC: 27,72 cm, sesuai: 32+5 minggu FL: 6,31 cm, sesuai: 32+5 minggu EFW/TBJ: 1900 gram, sesuai 32+3 minggu
Kecurigaan Temuan Abnormal	Ya/tidak*, Sebutkan .....

- DJJ: Denyut Jantung bayi, SDP: Ujuran, BPD: Biparietal Diameter/jarak tuluang parietal kepala, HC: Head Circumference/lingkar dada, AG: Abdominal Circumference/lingkar perut, PL: Femur Length/panjang tulang paha, EFW: Estimates Fetal Weight, TBU: Taksiran Berat bayi.
- *: Lingkari pilihan yang sesuai.

Pemeriksaan	Hasil	Rencana Tindak Lanjut
Hemoglobin	11,5 g/dL	
Protein Urin	— Mg/dL	
Urin Reduksi	Negatif/~~+~~ 1/+2/+3/+4	

Skrining Kesehatan Jiwa

Tanggal 24 Juni /26

Skrining Kesehatan Jiwa	Ya	Tidak
Tindak Lanjut Hasil Skrining Kesehatan Jiwa	Edukasi	Konseling
Perlu Rujukan	Ya	Tidak

Lingkari jawaban yang sesuai.

Rencana Konsultasi Lanjut tidak ada

Gizi	Kebidanan	Anak	Penyakit Dalam	Neurologi	THT	Psikiatri	Lain-lain

Rencana Proses Melahirkan

Normal	Pervaginam berbantu	Sectio caesaria

Pilihan Rencana Kontrasepsi

AKDR	Pil	Suntik	Steril
MAL	Implan	Belum memilih	

Konseling

Kebutuhan konseling	Ya	Tidak

Penjelasan _____

Kesimpulan: Rekomendasi Tempat Proses Melahirkan: FKTP~~/FKRTL~~ (coret salah satu).
Proses melahirkan dapat dilakukan di FKTP atau rujuk ke FKRTL.

BPD Biparietal Diameter
HC Head Circumferential
MAL Metode Amenore Laktasi
AC Abdominal Circumferential
FL Femur Length
SDP Cairan Ketuban Single Deepest Pocket Cairan Ketuban

Kesehatan Jiwa Ibu Hamil

1. **Tenaga kesehatan menyampaikan** informasi terkait kesehatan jiwa pada ibu hamil: apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan jiwa dan mengenali gejala gangguan kesehatan jiwa.
2. **Tenaga kesehatan mengingatkan** ibu, suami, dan keluarga untuk membaca pesan-pesan tersebut dirumah, dan dapat menanyakan ke tenaga kesehatan apabila ada informasi yang tidak dipahami.

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 1, 2 dan 3



Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 1 — Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 2 — Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 3 — Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali

Tenaga kesehatan mengisi tabel catatan pelayanan kesehatan ibu pada TM I, II dan III berdasarkan hasil pemeriksaan secara naratif ringkas, berupa:

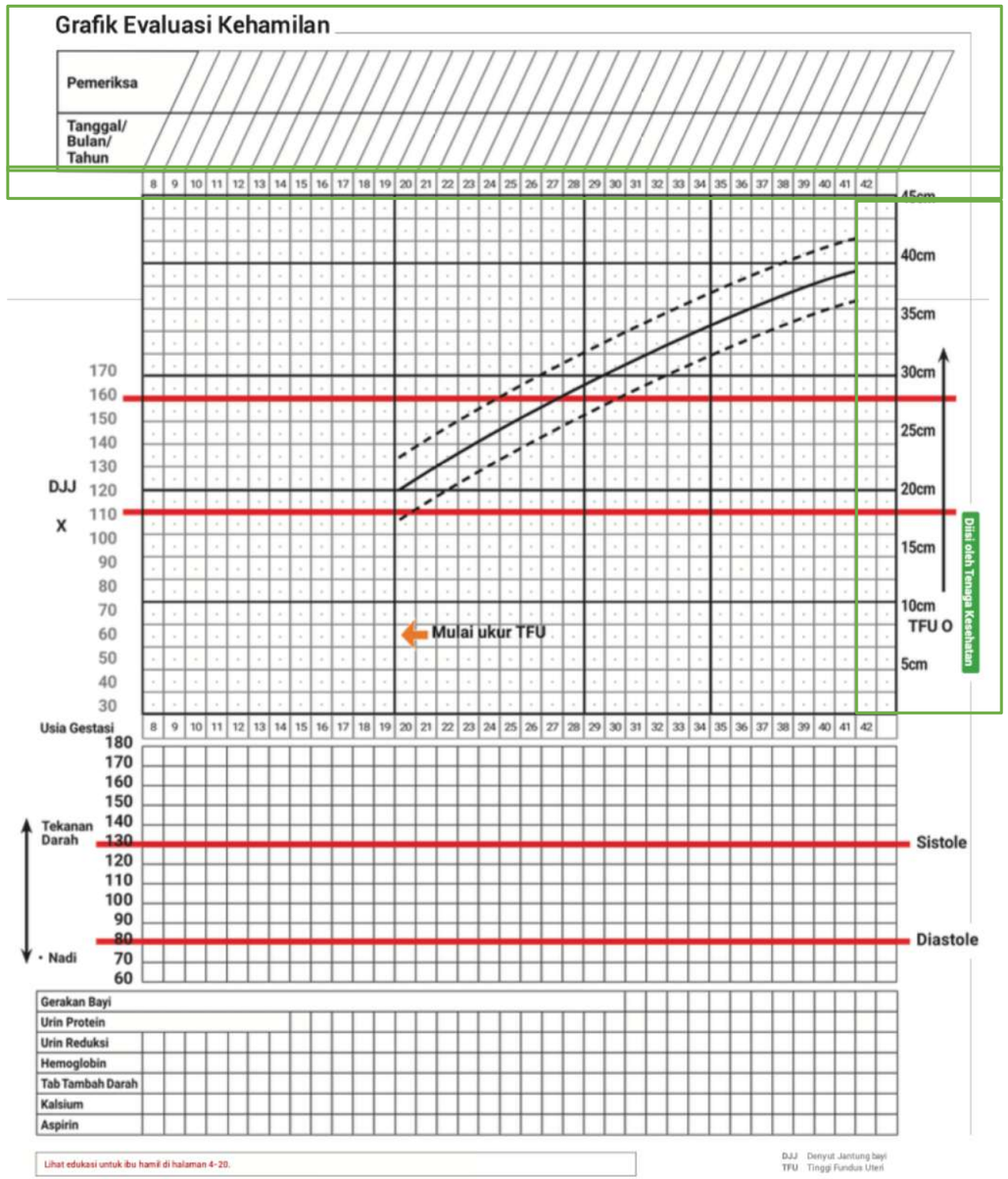
- Tanggal periksa, stempel faskes dan paraf nakes.
- Keluhan, hasil pemeriksaan, tatalaksana atau tindakan yang dilakukan oleh nakes dan saran nakes kepada ibu.
- Berikan catatan **tanggal kembali** lagi ke faskes, dan **pastikan nakes telah menyampaikan** informasi tanggal periksa kembali tersebut kepada ibu dan keluarga.
- **Lihat contoh dibawah ini:**

PENGUKURAN & PENCATATAN OLEH TENAGA KESEHATAN

Catatan Pelayanan Kesehatan Ibu Trimester 1 — Diisi oleh Tenaga Kesehatan

Tanggal Periksa, Stamp dan Paraf	Keluhan, Pemeriksaan, Tindakan dan Saran	Tanggal Kembali
10/02/26	Anemia ringan, suspek defisiensi besi T/ TTD 2x1 utk 4 mgg Cek ulang Hb tgl 10/3	10/03/26
10/03/26	Cek Hb ulang 11,2 T/ lanjutkan TTD 2x – evaluasi Hb 4mgg	07/04/26

Grafik Evaluasi Kehamilan

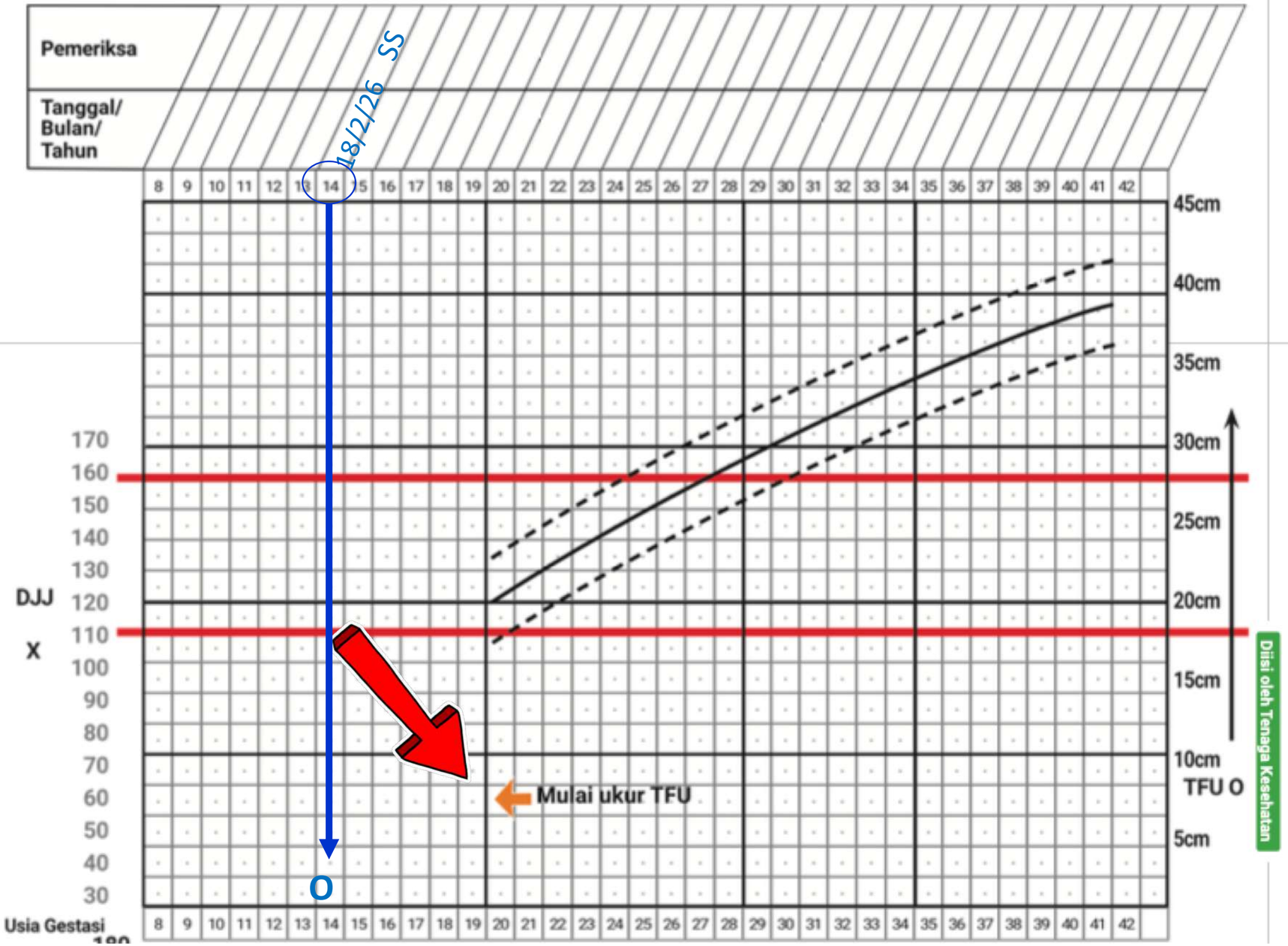


Tenaga kesehatan mengisi kolom “pemeriksa” dengan nama pemeriksa dan kolom ”tanggal/ bulan/ tahun” sesuai tanggal pemeriksaan.

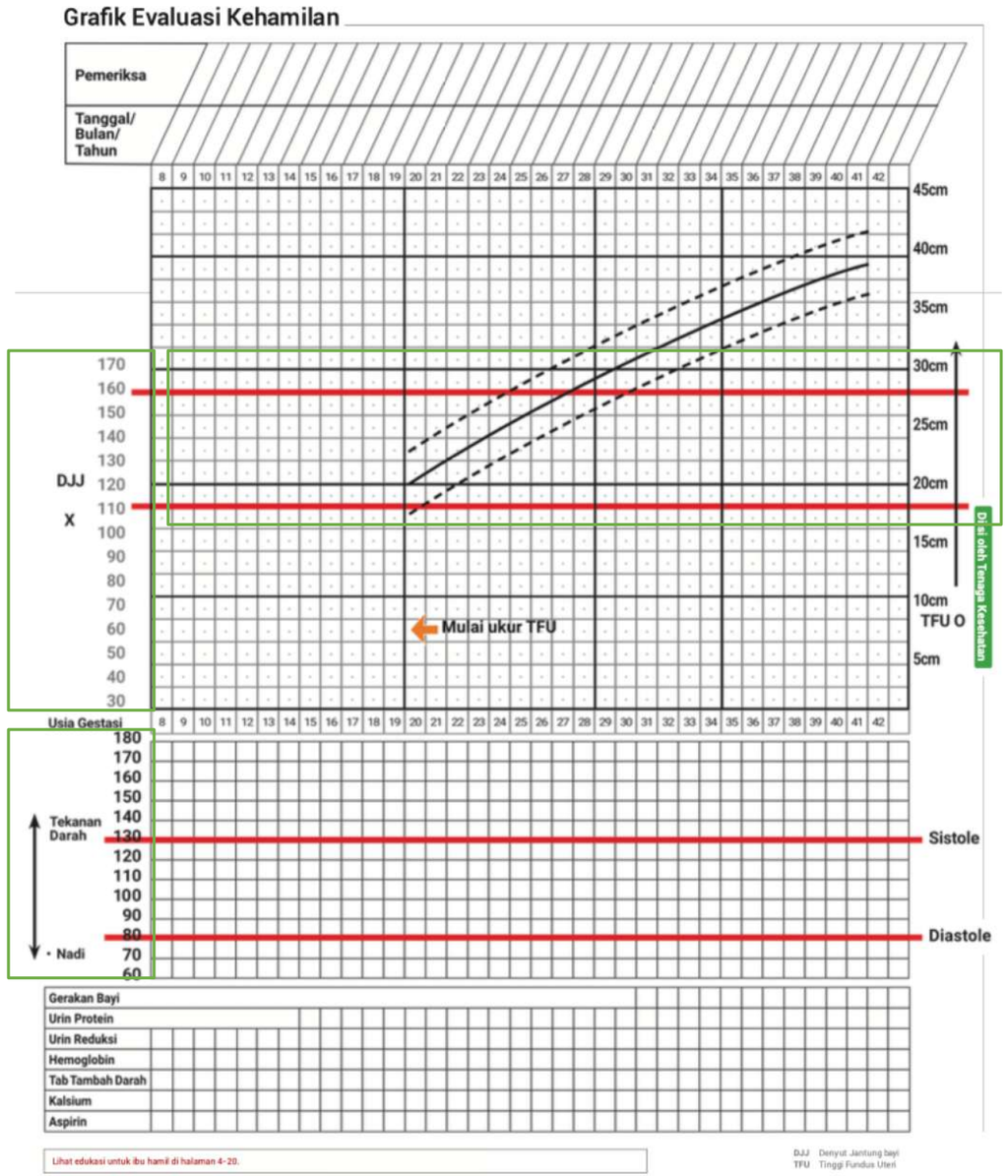
Tenaga kesehatan mengisi plotting grafik berdasarkan usia gestasi (dalam minggu) yang tertera pada kolom tersebut

Tenaga kesehatan memplotiing hasil pengukuran Tinggi fundus uteri (**TFU)**.
TFU adalah tinggi fundus uteri yang diukur dari simpisis ke puncak fundus dengan menggunakan pita ukur (dalam cm), plotting hasil pengukuran **dengan memberikan tanda bulatan/dots (.) pada titik yang sesuai TFU** dapat **diukur mulai usia kehamilan 20 minggu**

Grafik Evaluasi Kehamilan



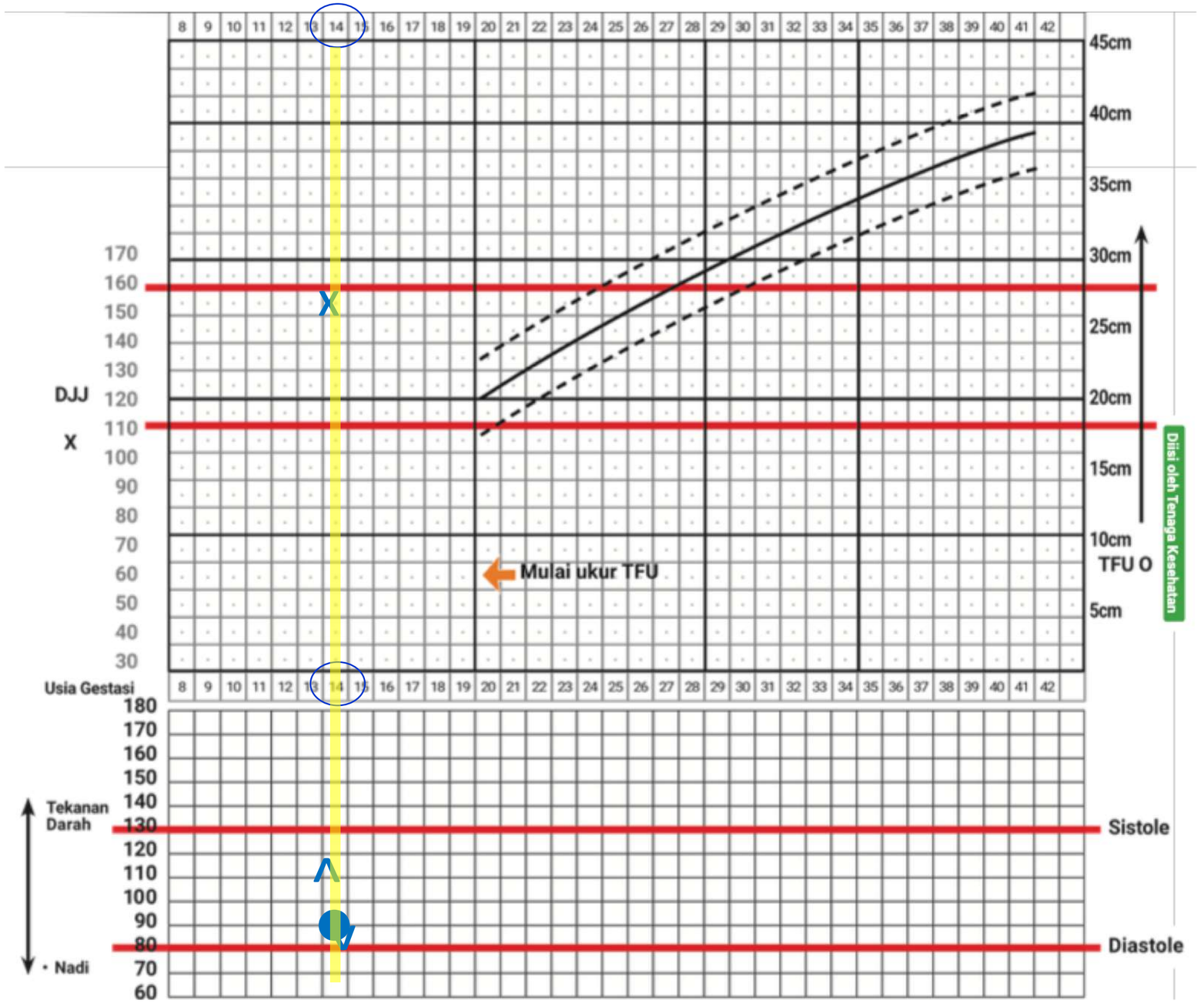
Grafik Evaluasi Kehamilan



Tenaga kesehatan memplotiing hasil pengukuran Denyut Jantung Janin (DJJ).
DJJ adalah denyut jantung janin yang didengarkan dan dihitung frekuensinya dalam 1 menit. **Plotting dengan memberikan tanda silang (x) pada titik yang sesuai**
Apabila DJJ berada di atas/lebih 160 atau dibawah 110 **segera lakukan rujuka**n (perhatikan batas garis merah)

Tenaga kesehatan memplotiing hasil pengukuran:

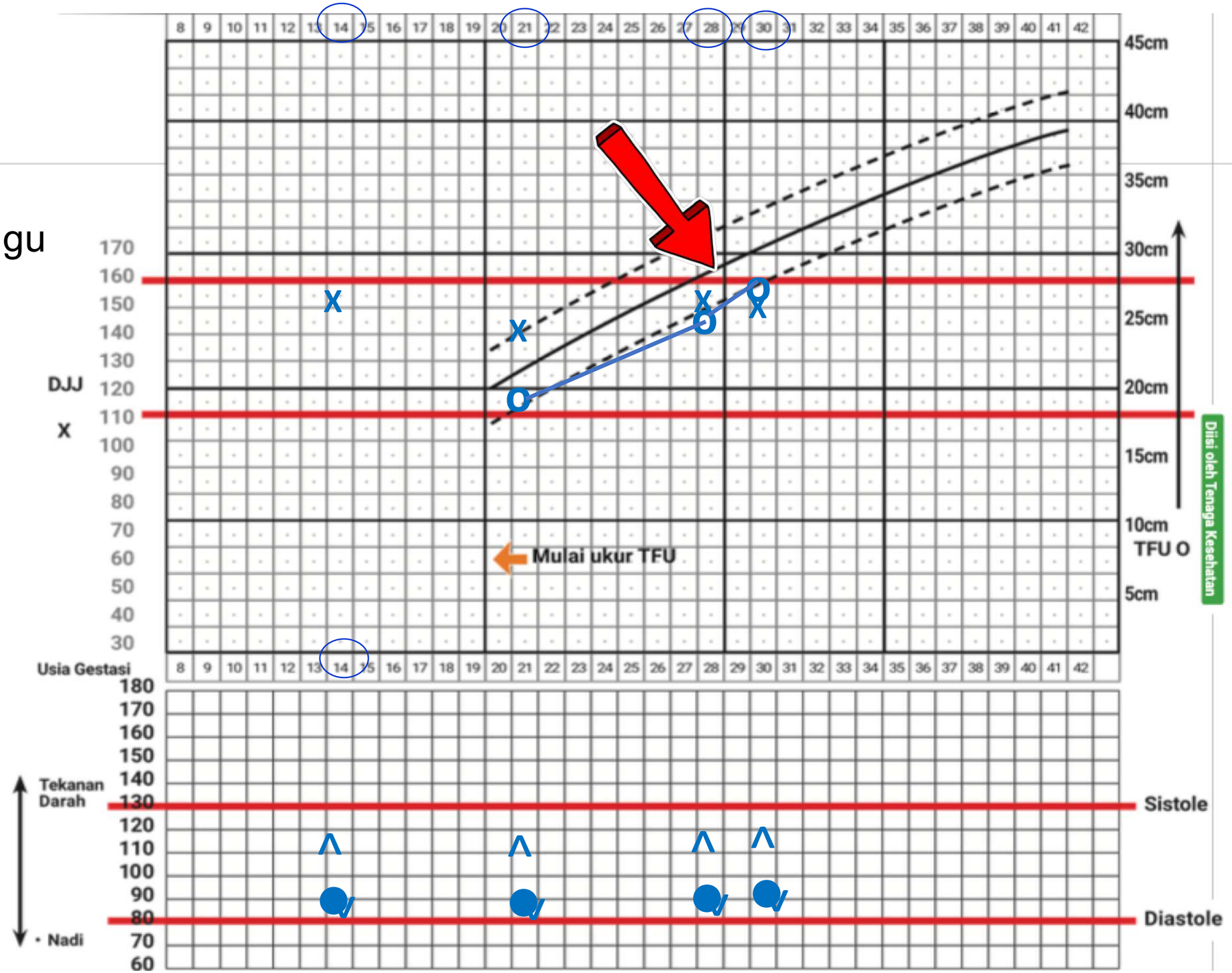
1. **Nadi ibu:** dihitung selama 1 menit, plotting dengan memberi tanda titik (.) pada titik yang sesuai
2. **Tekanan darah: tekanan darah** sistolik ditandai dengan (tanda panah ke atas) dan **tekanan darah diastolic** (tanda panah ke bawah).
3. Tandai perhitungan MAP pada grafik dengan tanda segitiga (▲), apabila MAP lebih dari 90 pada trimester PERTAMA maka risiko preeklamsi meningkat dan lakukan rujukan.


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
45cm
40cm
35cm
30cm
25cm
20cm
15cm
10cm
5cm
TFU O
DJJ
X
170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30
Mulai ukur TFU
Diisi oleh Tenaga Kesehatan
Usia Gestasi
180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60
Tekanan Darah
Nadi
Sistole
Diastole

Studi Kasus

Ny. 19 tahun

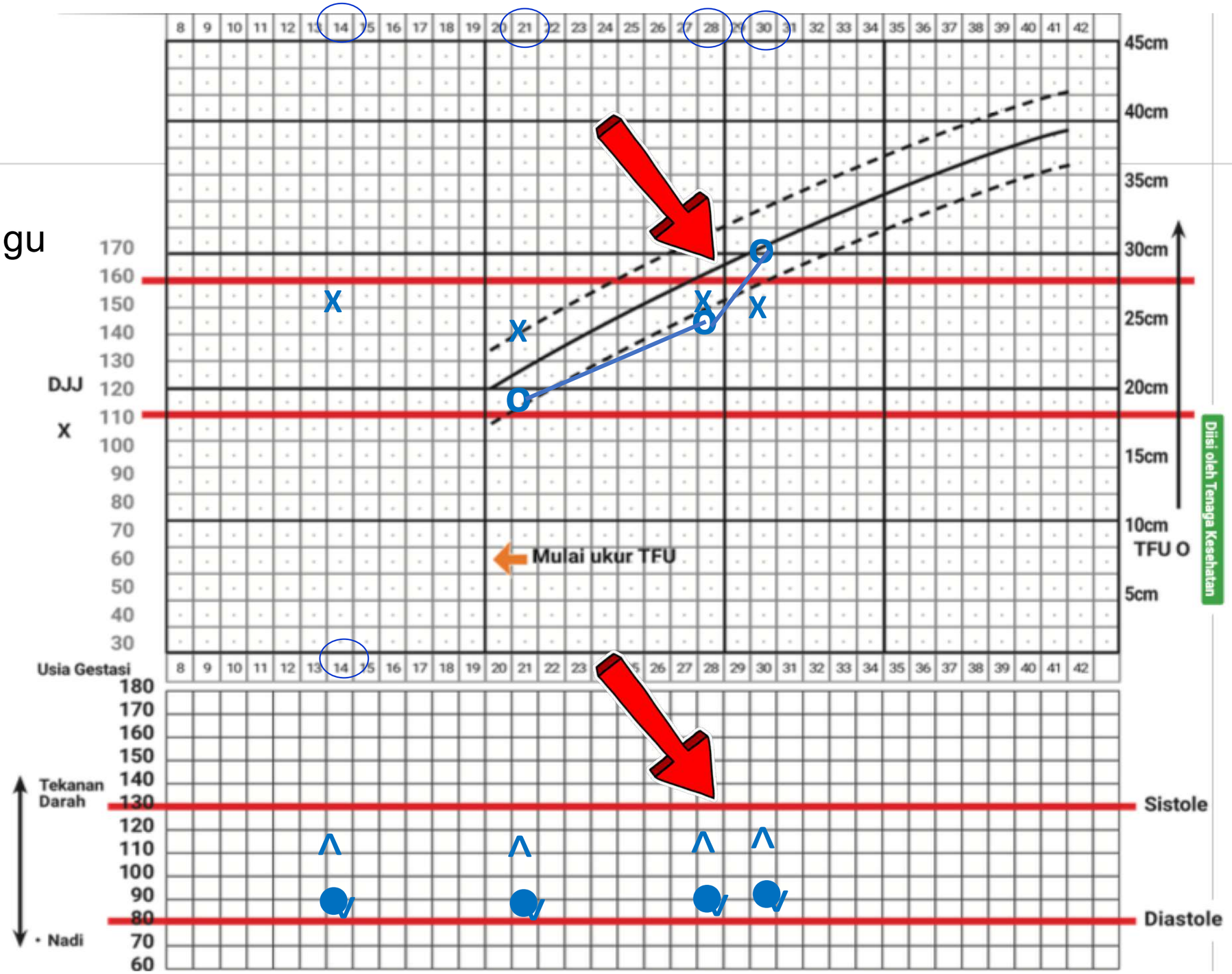
G1 hamil 32minggu

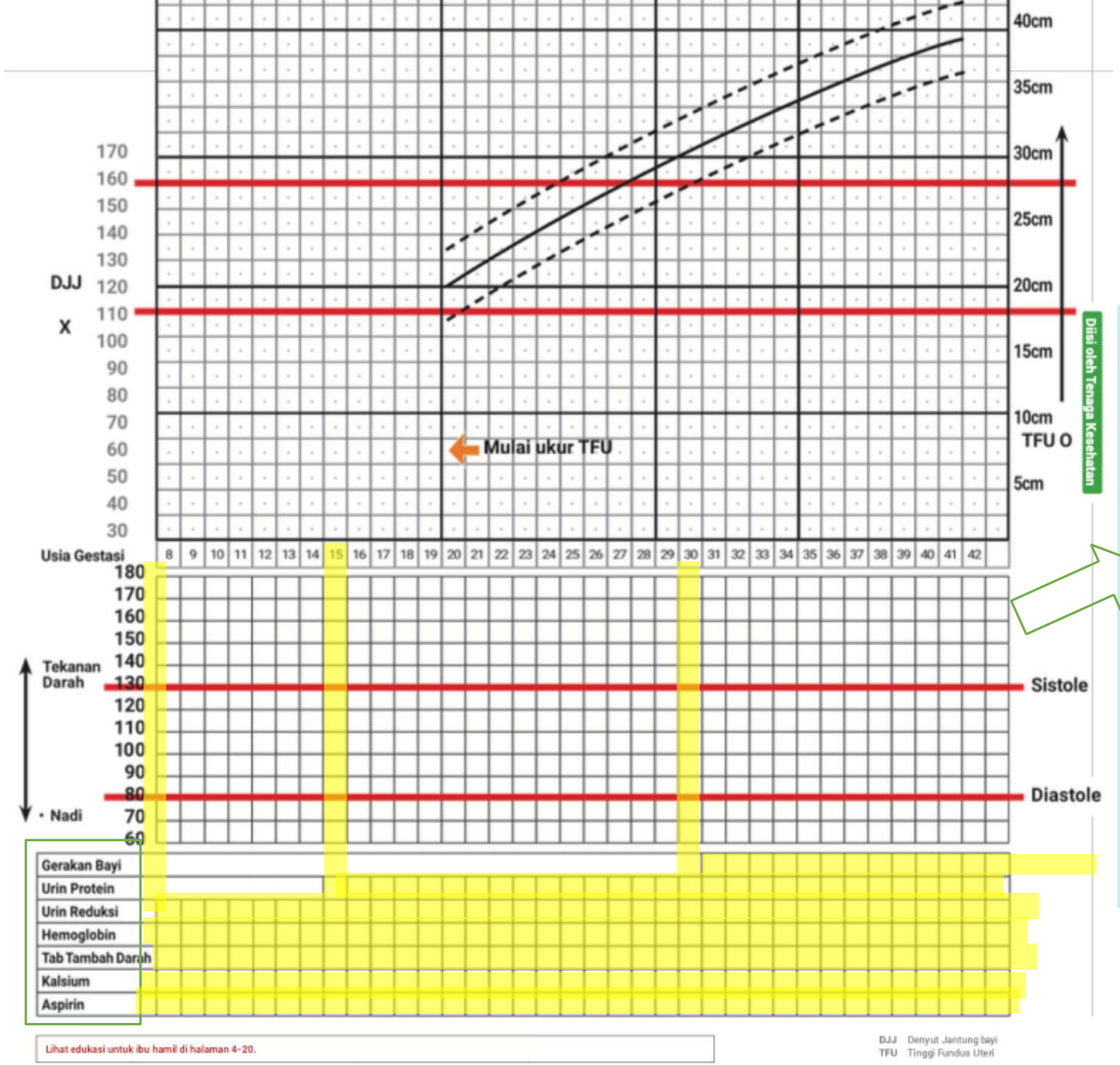


Studi Kasus

Ny. 19 tahun

G1 hamil 32minggu

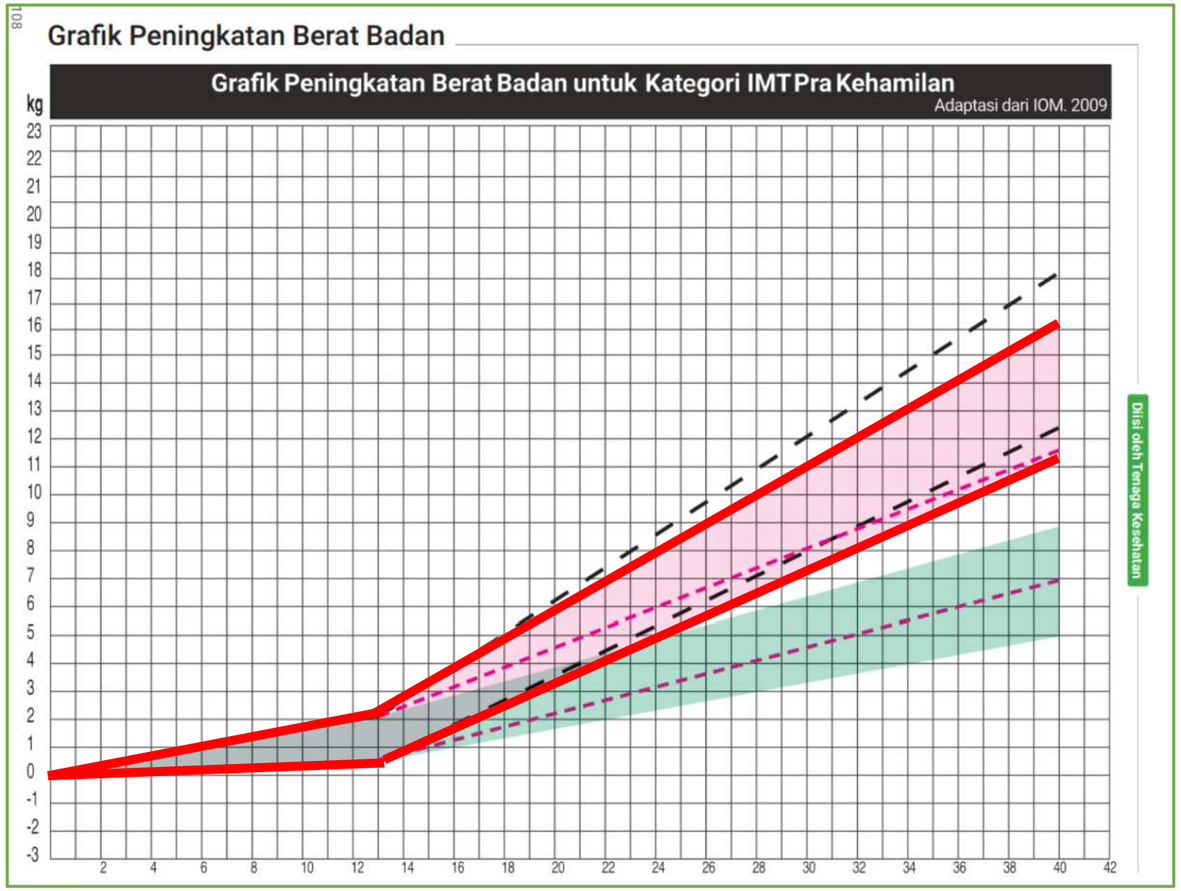




Tenaga kesehatan juga mengisi:

1. **Gerakan bayi:** gerakan bayi dinilai mulai dari kehamilan 30 minggu, tanyakan apakah gerakan bayi aktif atau tidak.
   - Bila gerakan bayi aktif yaitu lebih dari 10-12 kali dalam waktu 12 jam, maka **beri tanda positif (+)**
   - Bila kurang dari 10 kali dalam 12 jam, maka **beri tanda plus minus (±) dan lakukan rujukan,**
   - bila tidak ada Gerakan, maka **beri tanda negative (-) dan lakukan rujukan.**
2. **Urin Protein**: dilakukan pemeriksaan minimal dengan menggunakan dipstick, beri tanda pada kolom yang tersedia (-, +1, +2, dst)
3. **Urin Reduksi**: dilakukan minimal dengan menggunakan dipstick
4. **Haemoglobin**: tulis kadar Hb
5. **Kalsium dan aspirin**: pada ibu hamil dengan risiko preeklamsi maka diberikan kalsium 1500 gr/ hari dan aspirin 80 mg/hari. Tuliskan tanda (+) apabila ibu mendapatkan terapi kalsium dan atau aspirin

Grafik Peningkatan Berat Badan



Rumus IMT = $\frac{\text{Berat badan kg}}{(\text{Tinggi badan m})^2}$

Tenaga kesehatan melakukan perhitungan Indeks Masa Tubuh (IMT) pra/awal kehamilan dan mem-plotting grafik peningkatan berat badan **untuk memantau dan mengevaluasi penambahan berat badan ibu** selama kehamilan:

1. IMT pra/awal kehamilan dihitung berdasarkan BB ibu sebelum hamil atau pada saat awal kehamilan (dibawah 12 minggu). Lihat kategori IMT ibu pada tabel dibawah grafik.
2. Hasil penimbangan berat badan diplot pada grafik dengan **memberi tanda silang (X)** pada titik yang sesuai
3. Diharapkan kenaikan BB ibu hamil sesuai dengan rekomendasi IMT pra/awal kehamilan pada tabel. **Apabila kenaikan berat badan di luar rentang ideal dalam plotting IMT,** lakukan konsultasi dengan bagian gizi. Apabila dicurigai ketidaksesuaian kenaikan berat badan selama kehamilan lakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai dan lakukan rujukan

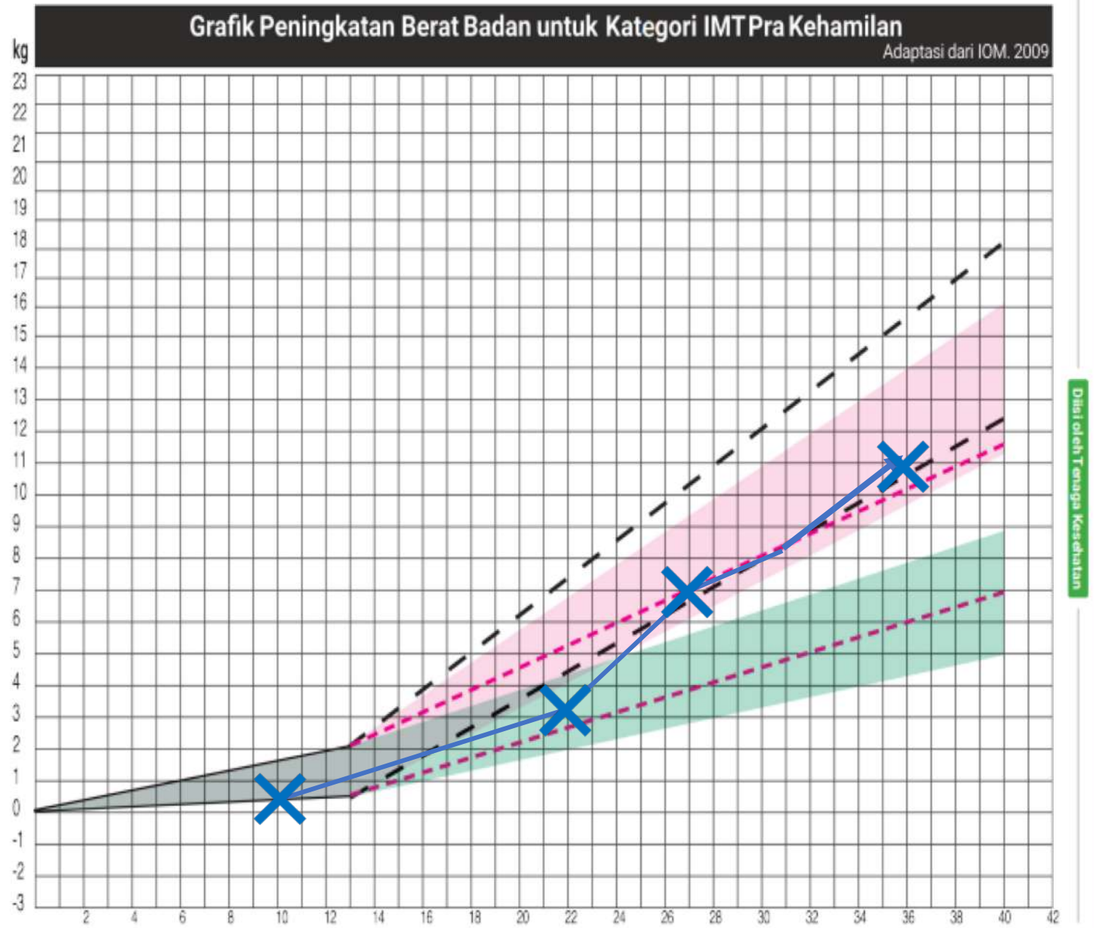
Tenaga kesehatan menandai IMT pra/awal kehamilan dengan melingkari kategori yang sesuai pada tabel.

Keterangan tabel:

- Area di antara garis putus-putus hitam: range kenaikan BB ibu hamil dengan KEK
- Area diantara blok warna pink: range kenaikan BB ibu hamil dengan BB prakehamilan normal
- Area di antara garis putus-putus pink: range kenaikan BB ibu hamil dengan BB prakehamilan gemuk
- Area diantara blok warna biru: range kenaikan BB ibu hamil dengan BB prakehamilan obesitas

Keterangan tambahan: Pada usia kehamilan sebelum 13 minggu kenaikan BB tidak memperhatian IMT pra/ awal kehamilan

Grafik Peningkatan Berat Badan



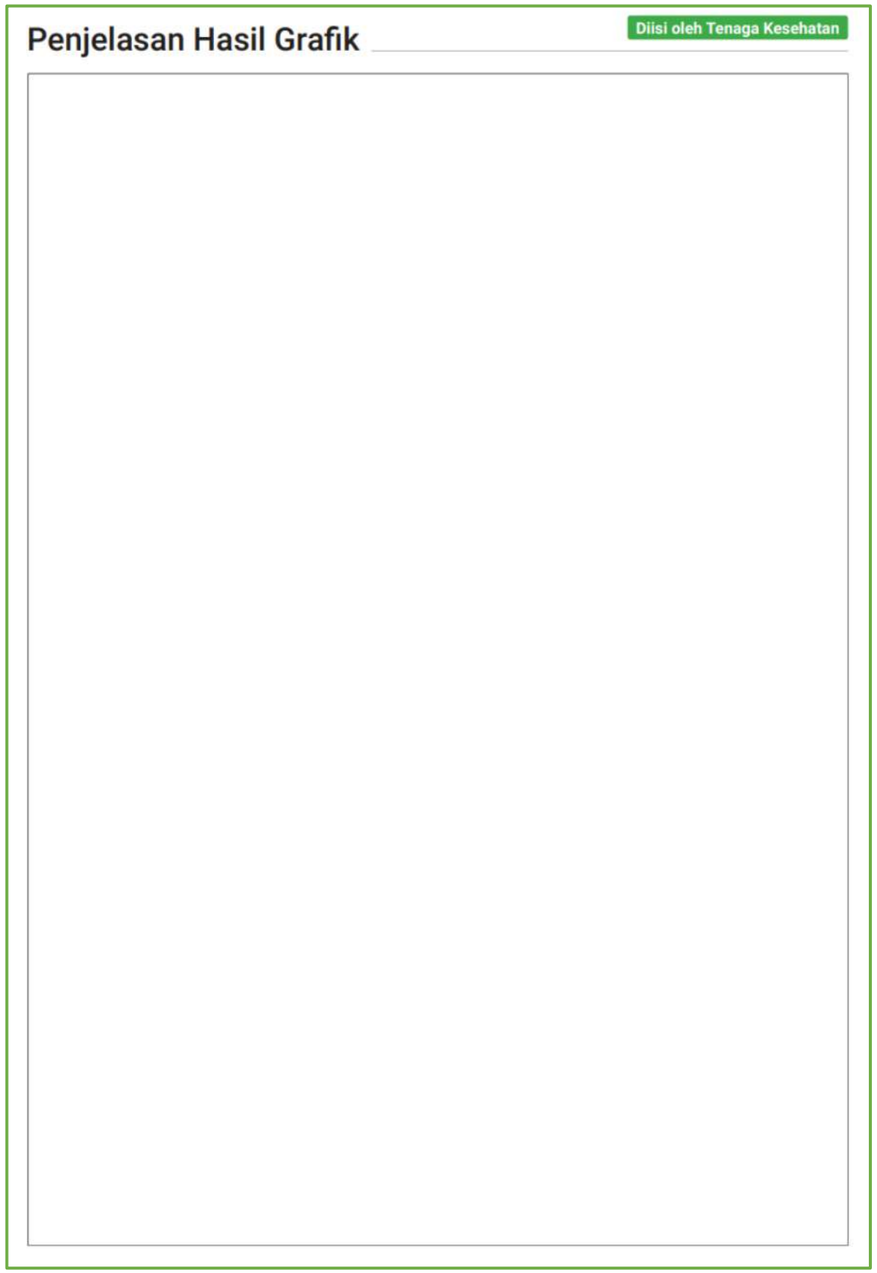
Tanda	BB Pra-kehamilan	IMT Pra-kehamilan	Rekomendasi Peningkatan Berat Badan
		<18,5	12,5 - 18 kg
		18,5 - 24,9	11,5 - 16 kg
		25 - 29,9	7 - 11,5 kg
		> 30	5 - 9 kg

Lihat edukasi untuk ibu hamil di halaman 4-20.

Diisi oleh Tenaga Kesehatan

- Peningkatan BB maternal diharapkan sejalan dengan kurva pada masing-masing kelompok IMT.
- Penyimpangan dari tren kurva harus dievaluasi: apakah ukurannya benar, apakah yang mungkin bisa menjadi penyebab – lakukan konsultasi dengan pihak terkait sesuai dengan analisis awal.
- Jika dibutuhkan lakukan pemeriksaan penunjang untuk emncari penyebab, dan lakukan pemeriksaan biometri untuk memastikan kondisi janin
- Lakukan konsultasi/rujukan ke FPKTL sesuai dengan indikasi

Penjelasan Hasil Grafik



Tenaga kesehatan memberikan penjelasan hasil grafik sesuai hasil plotting pada grafik kenaikan berat badan dan grafik evaluasi kehamilan serta memberikan rekomendasi tindak lanjut. Lakukan rujukan apabila isi grafik evaluasi kehamilan atau berat badan tidak normal

Terima kasih sudah berusaha menyelamatkan bundaku....

